AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

SERIE AEE · PERFIL V3

REPASO FINAL

OFTALMOLOGÍA

Ojo rojo, Glaucoma & Retina

18 temas · 1 página cada uno · **7** días de plan de repaso

Índice

Cómo usarlo. Un tema por página: lee «Lo que te preguntan», recorre el algoritmo y termina en las trampas y la regla de oro. Después haz las preguntas del Libro Gordo que indica el pie.

★★★ alta · ★★☆ media · ★☆☆ baja — según cuántas preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) hay en los códigos del tema.
Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento.

01 Síndrome de Ojo Rojo & Superficie Ocular

★★☆ 15.1. Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo 3
★★★ 15.2. Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas 4
★★★ 15.3. Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis 5
★★☆ 15.4. Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides) 6
★☆☆ 15.5. Escleritis y Episcleritis: Prueba de Fenilefrina y Enfermedades Reumatológicas 7

02 Glaucoma & Patología del Cristalino

★★☆ 15.6. Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida 8
★★★ 15.7. Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG 9
★★★ 15.8. Cataratas: Diagnóstico, Indicación Quirúrgica y Facoemulsificación GES 10
★★★ 15.9. Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños GES 11

03 Pérdida Súbita de Visión & Retina

★★☆ 15.10. Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo GES 12
★☆☆ 15.11. Oclusión Vascular Retinal: Arteria (Mancha Rojo Cereza) vs Vena Central 13
★★★ 15.12. Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES GES 14
★☆☆ 15.13. Retinopatía Hipertensiva: Cruces AV, Exudados Algodonosos y Edema Papilar 15
★★★ 15.14. Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y Escotoma Central 16

04 Trauma Ocular & Neuroftalmología

★★☆ 15.15. Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta GES 17
★★☆ 15.16. Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso GES 18
★★☆ 15.17. Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC 19
★★★ 15.18. Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn GES 20

Números que tienes que saber 21
Fármacos de primera línea 23
GES de la especialidad 23
Plan de repaso de 7 días 25
Índice por prioridad ★ 26

BLOQUE 01 · SÍNDROME DE OJO ROJO & SUPERFICIE OCULAR

15.1 Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

2.01.1.097 Ojo rojo — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Glaucoma agudo · Uveítis anterior o posterior · Queratitis · Pterigion

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Ojo rojo profundo** = inyección ciliar/periquerática violácea, dolor ocular sordo y disminución de agudeza visual.
- **Ojo rojo superficial** = inyección conjuntival periférica, secreción, sensación de arenilla y agudeza visual normal.
- **Los 5 signos de alarma obligan a derivación urgente**: baja de AV, dolor ocular real, alteración pupilar, hipopión/hipema y córnea opaca/fluo+.
- La miosis hiporreactiva orienta a uveítis anterior; la midriasis media fija orienta a glaucoma agudo.
- El hiposfagma es indoloro, no afecta la visión y no requiere tratamiento farmacológico: se resuelve solo en **2 semanas**.



INYECCIÓN CONJUNTIVAL
Manual CTO Oftalmología 14.ª ed., p. 33

ALGORITMO · OJO ROJO: SUPERFICIAL VERSUS PROFUNDO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

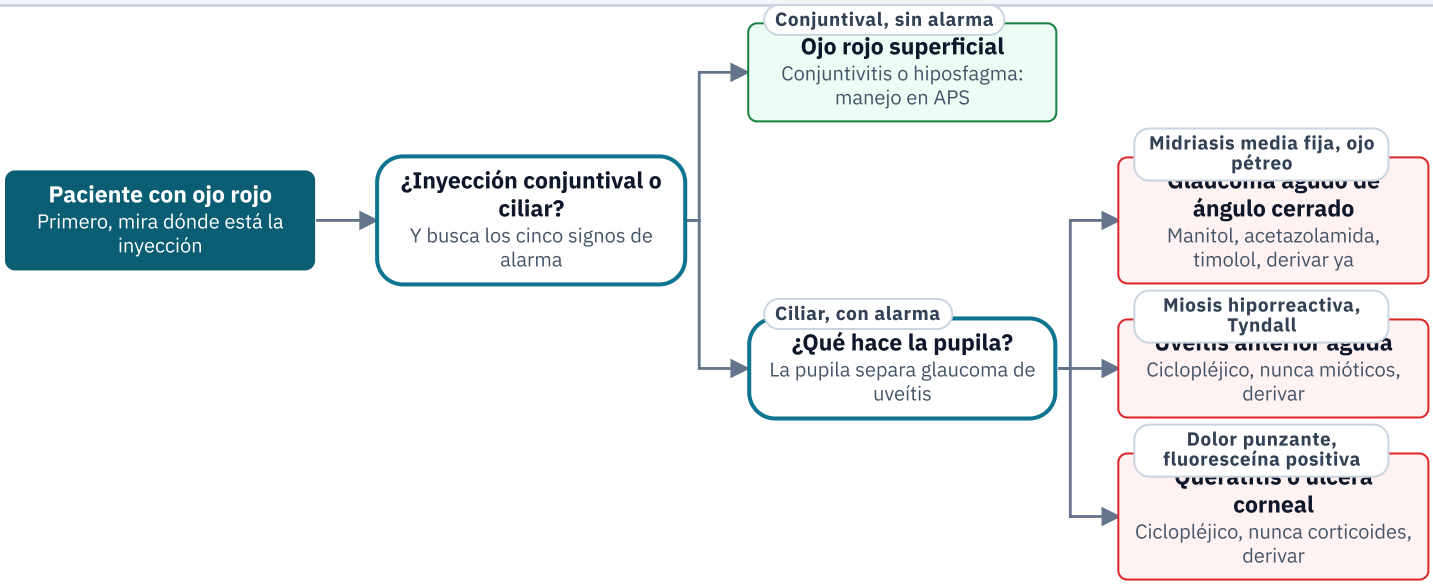


TABLA 15.1 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL OJO ROJO SEGÚN LOCALIZACIÓN Y SIGNOS CLÍNICOS

CARACTERÍSTICA	CONJUNTIVITIS	UVEÍTIS ANTERIOR	GLAUCOMA AGUDO	QUERATITIS
Inyección	Conjuntival periférica	Ciliar / Periquerática	Mixta / Periquerática intensa	Ciliar / Periquerática
Dolor ocular	Ausente (solo prurito/arenilla)	Moderado a severo	Lancinante, muy severo	Intenso + Blefarospasmo
Agudeza visual	Normal	Disminución leve-moderada	Disminución severa	Disminución variable
Pupila	Normal, reactiva	Miosis hiporreactiva	Midriasis media fija	Normal o miosis refleja
Córnea	Transparente	Transparente (precipitados retro)	Opaca / Vidrio esmerilado	Infiltrado / Úlcera fluo+
Secreción	Mucopurulenta o serosa	Acuosa / Sin secreción	Acuosa / Sin secreción	Acuosa a purulenta

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

HALLAZGO	DIAGNÓSTICO QUE SUGIERE	TRAMPA FRECUENTE
Ojo rojo con fluoresceína positiva	Queratitis o úlcera corneal	Indicar corticoides para desinflamar
Mancha roja homogénea, indolora, visión normal	Hiposfagma	Indicar colirio antibiótico o hemostático
Cualquiera de los cinco signos de alarma	Derivación urgente a oftalmología	Tratar en APS y controlar en días

REGLA DE ORO **Inyección conjuntival, sin dolor real** — Superficial: se maneja en APS

PRACTICA **Libro Gordo Oftalmología**, preguntas **3–8** (pág. 6) · solucionario págs. 17–18.

Clase 15.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SÍNDROME DE OJO ROJO & SUPERFICIE OCULAR

15.2 Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas

★★★ PRIORIDAD ALTA
7 preguntas reales 2013–2025

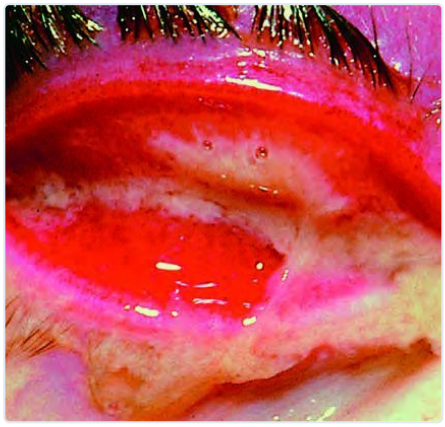
Muy alta · Diagnóstico diferencial entre etiología bacteriana, viral y gonocócica neonatal

6.02.1.005 **Conjuntivitis bacteriana aguda** — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Conjuntivitis viral no complicada · Conjuntivitis no infecciosa · Conjuntivitis aguda · Conjuntivitis bacteriana crónica · Cultivo de secreción conjuntival · Aplicación de ungüentos

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Conjuntivitis bacteriana** = secreción purulenta matutina con pestañas aglutinadas; responde a cloranfenicol colirio.
- **Conjuntivitis viral (Adenovirus)** = secreción acuosa + folículos + adenopatía preauricular dolorosa; altamente contagiosa.
- **Conjuntivitis alérgica** = PRURITO intenso y bilateral; responde a antihistamínicos tópicos (olopatadina).
- La conjuntivitis hiperaguda por gonococo genera pus abundante en chorro y perfora la córnea: requiere Ceftriaxona IM/EV.
- En ninguna conjuntivitis está justificado el uso de corticoides tópicos en atención primaria.



BACTERIANA
Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 147

ALGORITMO · LAS CUATRO CONJUNTIVITIS: TRES PREGUNTAS

☐ urgencia ☐ resuelve ☐ derivar ☐ examen/acción



TABLA 15.2 · DIFERENCIACIÓN CLÍNICA DE LAS CONJUNTIVITIS MÁS FRECUENTES

CRITERIO	BACTERIANA SIMPLE	VIRAL (ADENOVIRUS)	ALÉRGICA	GONOCÓCICA
Secreción	Mucopurulenta, espesa	Acuosa o serosa	Acuosa / mucosa filamentosa	Purulenta masiva en chorro
Síntoma cardinal	Pestañas pegadas al despertar	Sensación arenilla + contagio	PRURITO intenso bilateral	Quemosis masiva + pus
Adenopatía preauricular	Ausente	Presente y dolorosa (típica)	Ausente	Presente y dolorosa
Reacción conjuntival	Papilar leve	Folicular inferior	Papilas en empedrado	Quemosis hemorrágica
Tratamiento de elección	Cloranfenicol tópico 7 días	Sintomático + Aislamiento	Olopatadina colirio 0.1%	Ceftriaxona IM/EV urgente

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO CLÍNICO	DIAGNÓSTICO	TRAMPA FRECUENTE
Prurito bilateral intenso	Alérgica	Partir con un colirio de corticoide
Más de 4 semanas, costras matinales	Blefaroconjuntivitis crónica	Repetir el colirio sin higiene palpebral

REGLA DE ORO **Mucopurulenta y pegajosa: bacteriana** — Acuosa con adenopatía: viral

PRACTICA **Libro Gordo Oftalmología**, preguntas **9–11** (pág. 7) · solucionario pág. 18.

Clase 15.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SÍNDROME DE OJO ROJO & SUPERFICIE OCULAR

15.3 Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis

★★★
PRIORIDAD ALTA
6 preguntas reales 2013–2025

6.02.1.019 Orzuelo no complicado — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Chalazion · Blefaritis · Dacriocistitis aguda · Obstrucción completa de la vía lacrimal · Tumores de párpado · Extracción de pestañas distiquiásicas · Tumores de conjuntiva

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Orzuelo** = nódulo agudo, eritematoso y MUY DOLOROSO en el borde palpebral; se trata con calor local y antibiótico tópico.
- **Chalazión** = nódulo crónico INDOLORO en el espesor del párpado por retención sebácea; curetaje si persiste >**2 meses**.
- **Blefaritis** = inflamación crónica del borde palpebral; el tratamiento pilar es la higiene diaria con champú neutro.
- **Dacriocistitis aguda** = masa roja y muy dolorosa en el canto interno del ojo con epífora; requiere antibióticos sistémicos orales.
- En dacriocistitis aguda está PROHIBIDO realizar sondaje de la vía lagrimal por riesgo de diseminación orbitaria.



ORZUELO
Manual AMIR Oftalmología, p. 57

ALGORITMO · PÁRPADOS Y SACO LAGRIMAL: CUATRO CUADROS

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

Nódulo, inflamación o masa periocular
Primero, ¿dónde está?

¿En el párpado o en el canto interno?
Después decide el dolor

- Párpado, agudo y doloroso → **Orzuelo**: Compresas tibias + ungüento antibiótico
- Párpado, crónico e indoloro → **Chalazión**: Calor local; curetaje si pasa de 2 meses
- Borde palpebral, crónico y con escamas → **Blefaritis**: Higiene palpebral diaria
- Canto interno, rojo y doloroso → **Dacriocistitis aguda**: Antibiótico oral; nunca sondar

TABLA 15.3 · COMPARACIÓN SEMIOLOGÍA: ORZUELO, CHALAZIÓN, BLEFARITIS Y DACRIOCISTITIS

PATOLOGÍA	ESTRUCTURA AFECTADA	ETIOLOGÍA	SEMIOLOGÍA CARDINAL	CONDUCTA DE PRIMERA LÍNEA
Orzuelo	Glándulas de Zeiss/Moll o Meibomio	Infecciosa aguda (S. aureus)	Nódulo eritematoso agudo y muy DOLOROSO	Calor local húmedo + pomada antibiótica
Chalazión	Glándula de Meibomio	Granulomatosa lipídica crónica	Nódulo duro en tarso, INDOLORO, piel móvil	Calor local; curetaje si > 2 meses
Blefaritis	Borde libre palpebral y pestañas	DGM / Seborrea / S. aureus	Escamas en pestañas, ardor crónico, hiperemia	Higiene palpebral diaria con champú neutro
Dacriocistitis	Saco lagrimal (canto interno)	Obstrucción nasolagrimal + bacteria	Masa dolorosa y roja inferomedial + epífora	Amoxicilina/clavulánico oral; no sondar

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

HALLAZGO	DIAGNÓSTICO	TRAMPA FRECUENTE
Nódulo firme, indoloro, crónico	Chalazión	Operarlo antes de intentar tratamiento médico
Úlcera que no cicatriza, madarosis	Carcinoma basocelular	Cauterizar o tratar en APS

REGLA DE ORO **Agudo y doloroso: orzuelo** — Crónico e indoloro: chalazión

PRACTICA **Libro Gordo Oftalmología**, preguntas **12–15, 37, 55, 73–74** (págs. 7, 10, 12, 15) · solucionario págs. 18, 21, 24, 26.

Clase 15.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SÍNDROME DE OJO ROJO & SUPERFICIE OCULAR

15.4 Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides)

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

6.02.1.021 Queratitis — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Úlcera corneal · Leucoma corneal

LO QUE TE PREGUNTAN

- Úlcera dendrítica ramificada con bulbos terminales teñida con fluoresceína = Queratitis herpética por VHS-1.
- **CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA**: JAMÁS prescribir corticoides tópicos en úlceras herpéticas (producen úlcera geográfica y perforación).
- El tratamiento de elección de la queratitis herpética es Aciclovir oftálmico en pomada al **3%** (**5 veces** al día).
- En usuarios de lentes de contacto con infiltrado corneal blanco, sospechar Pseudomonas aeruginosa y derivar de urgencia.
- La queratitis del soldador (actínica) es bilateral, cursa con queratitis punteada superficial difusa y cura en **24-48 horas** con lubricantes.
- Los anestésicos locales tópicos solo se usan para el examen diagnóstico en el box; su uso repetido destruye el epitelio corneal.



ÚLCERA DENDRÍTICA
Manual CTO Oftalmología 14.ª ed., p. 40

ALGORITMO · QUERATITIS: EL PATRÓN DE TINCIÓN DECIDE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

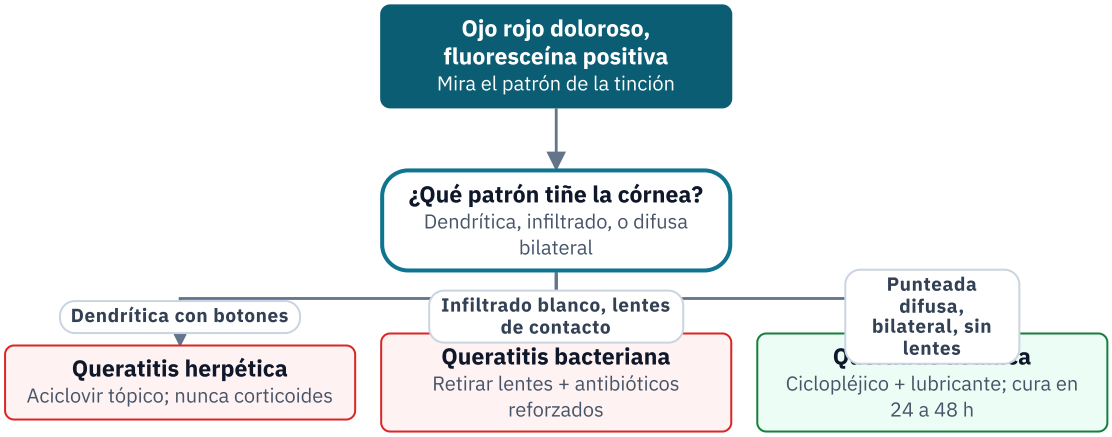


TABLA 15.4 · QUERATITIS HERPÉTICA VS QUERATITIS BACTERIANA VS QUERATITIS ACTÍNICA

TIPO DE QUERATITIS	FACTOR DESENCADENANTE	PATRÓN DE TINCIÓN CON FLUORESCEÍNA	TERAPIA DE ELECCIÓN	ERROR FATAL A EVITAR
Herpética (VHS-1)	Estrés, fiebre, inmunodepresión	Úlcera dendrítica ramificada con botones	Aciclovir tópico 3% pomada	USO DE CORTICOIDES TÓPICOS
Bacteriana (Pseudomonas)	Lentes de contacto blandos	Infiltrado estromal blanco + hipopión	Ceftazidima / Moxifloxacino	Ocluir el ojo con parche
Actínica (Soldador / Nieve)	Exposición a rayos UV sin gafas	Queratitis punteada difusa superficial	Ciclopléjico + Pomada lubricante	Uso repetido de anestésico tópico
Fúngica (Fusarium)	Trauma con vegetal / rama de árbol	Infiltrado con bordes plumosos y lesiones satélite	Voriconazol / Natamicina tópica	Tratar como infección bacteriana

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

HALLAZGO	DIAGNÓSTICO	TRAMPA FRECUENTE
Dolor bilateral tras exposición a luz UV sin protección	Queratitis actínica	Usar anestésico tópico de forma repetida
Cualquier úlcera o infiltrado corneal	Derivación prioritaria a oftalmología	Tratar solo con antibiótico tópico sin derivar

REGLA DE ORO **Luz azul de cobalto** — El examen de cabecera ante dolor corneal

PRACTICA **Libro Gordo Oftalmología**, preguntas **16–18** (págs. 7–8) · solucionario pág. 19.

Clase 15.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SÍNDROME DE OJO ROJO & SUPERFICIE OCULAR

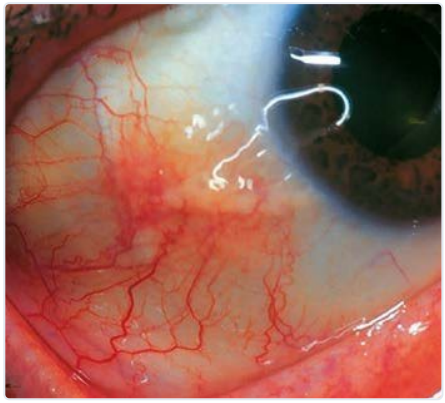
15.5 Escleritis y Epiescleritis: Prueba de Fenilefrina y Enfermedades Reumatológicas

★☆☆
PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

2.01.1.097 Ojo rojo — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- La prueba de fenilefrina al **2.5%** blanquea la epiescleritis pero NO blanquea la escleritis.
- La epiescleritis cursa con molestia leve y es benigna; la escleritis produce un dolor terebrante nocturno insoportable.
- Más del **50%** de las escleritis se asocian a enfermedades reumatológicas sistémicas, principalmente Artritis Reumatoide.
- La escleritis NO responde a colirios tópicos; exige AINEs orales o corticoides sistémicos e inmunosupresores.
- La escleromalacia perforante es el adelgazamiento escleral grave indoloro en pacientes con artritis reumatoide de larga data.



EPIESCLERITIS
Manual AMIR Oftalmología, p. 47

ALGORITMO · OJO ROJO PROFUNDO: LA FENILEFRINA DECIDE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

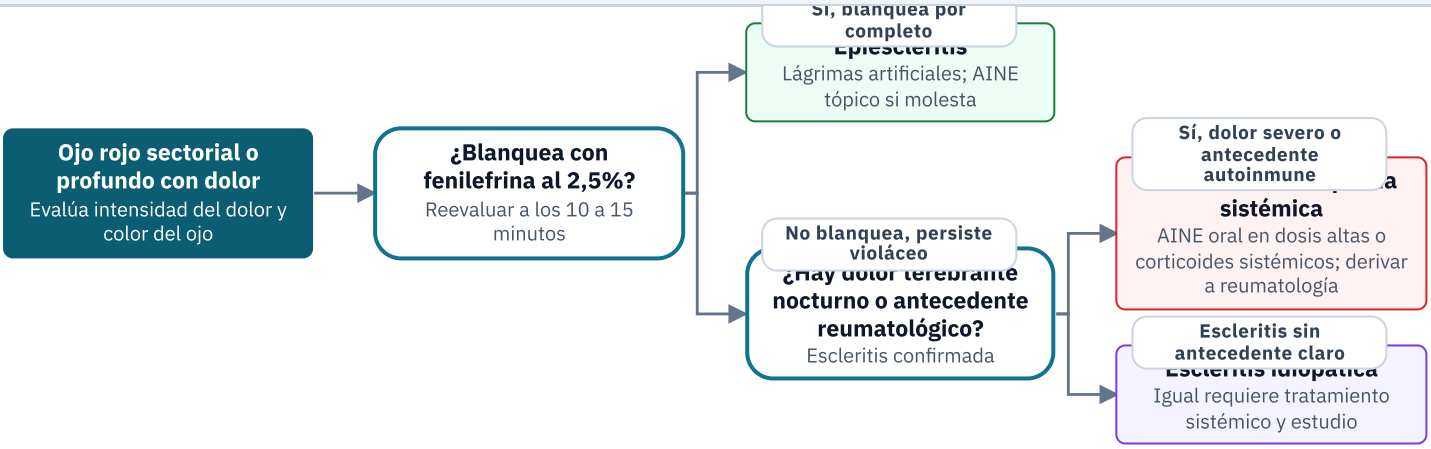


TABLA 15.5 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: EPIESCLERITIS VS ESCLERITIS ANTERIOR

PARÁMETRO	EPIESCLERITIS	ESCLERITIS ANTERIOR
Dolor ocular	Leve molestia, ardor o sensación de arenilla	Dolor sordo, TEREBRANTE, severo, que despierta de noche
Tonalidad del ojo	Rojo salmón / rojo brillante sectorial	Rojo oscuro / violáceo azulado difuso o nodular
Test de Fenilefrina 2.5%	BLANQUEA (vasoconstricción completa)	NO BLANQUEA (persiste congestión profunda)
Asociación sistémica	Rara (< 20%, idiopática habitual)	> 50% autoinmune (Artritis Reumatoide, Wegener)
Amenaza visual	Nula (benigna, autolimitada)	Alta (adelgazamiento, escleromalacia, perforación)
Tratamiento	Lágrimas artificiales, AINE tópico si molesta	AINE orales, corticoides sistémicos, inmunosupresores

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

PARÁMETRO	EPIESCLERITIS	ESCLERITIS
Prueba de fenilefrina	Blanquea por completo	No blanquea, persiste el enrojecimiento

REGLA DE ORO **Blanquea: epiescleritis** — No blanquea: escleritis

PRACTICA **Libro Gordo Oftalmología**, preguntas **21–23** (pág. 8) · solucionario pág. 19.

Clase 15.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · GLAUCOMA & PATOLOGÍA DEL CRISTALINO

15.6 Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida

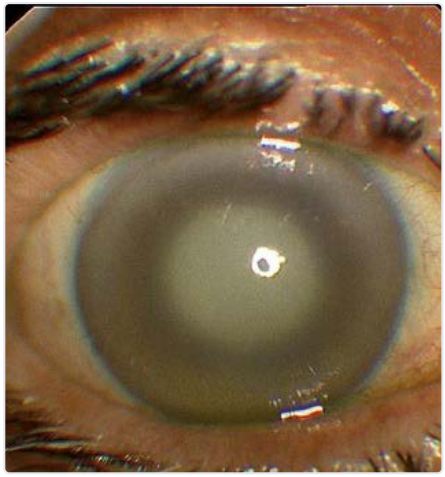
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

6.02.2.005 Glaucoma agudo — Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Tensión ocular palpatoria

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Glaucoma agudo** = dolor ocular brutal + náuseas/vómitos + visión borrosa con halos + ojo pétreo.
- El signo pupilar patognomónico es la MIDRIASIS MEDIA FIJA Y ARREACTIVA unilateral.
- **Manejo farmacológico inicial de rescate**: Manitol **20%** EV + Acetazolamida oral + Timolol **0.5%** tópico.
- La pilocarpina solo es útil cuando la PIO ha bajado a < **30 mmHg** (antes el esfínter pupilar está paralizado).
- El tratamiento definitivo es la Iridotomía periférica con láser YAG, que debe realizarse siempre en AMBOS ojos.
- **CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA**: JAMÁS administrar colirios midriáticos (atropina, tropicamida) en un cierre angular.



GLAUCOMA AGUDO
Manual AMIR Oftalmología, p. 36

ALGORITMO · CEFALEA CON OJO ROJO: DESCARTA EL GLAUCOMA AGUDO PRIMERO

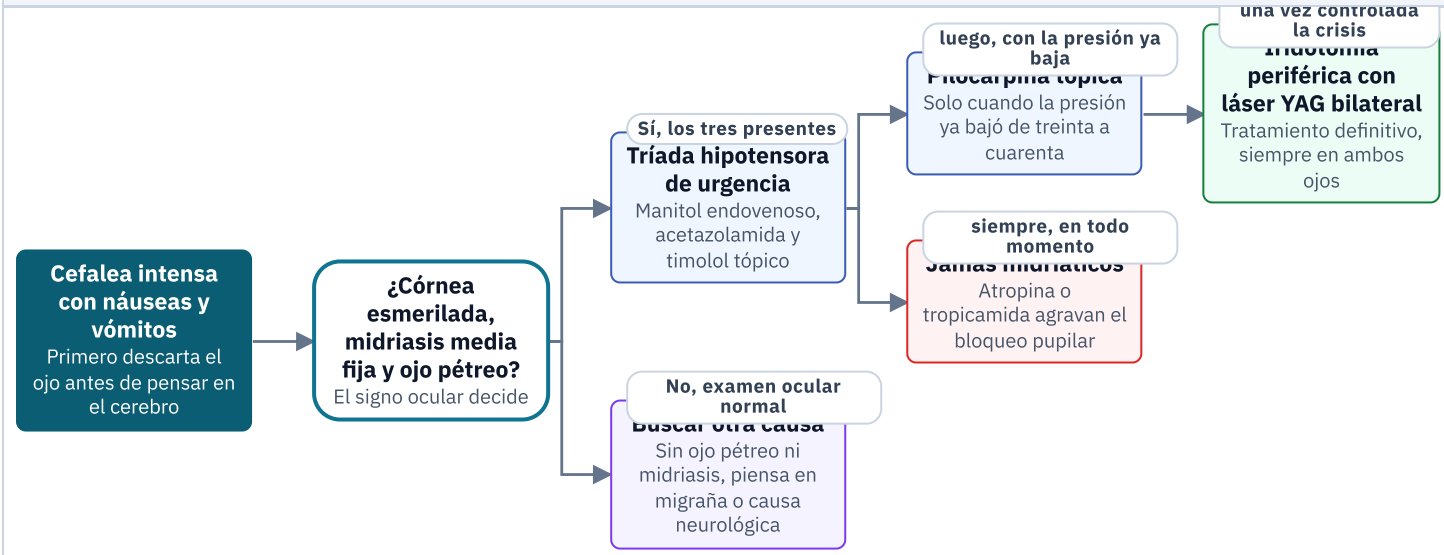


TABLA 15.6 · GLAUCOMA AGUDO DE ÁNGULO CERRADO VS UVEÍTIS ANTERIOR AGUDA

CARACTERÍSTICA SEMIOLÓGICA	GLAUCOMA AGUDO DE ÁNGULO CERRADO	UVEÍTIS ANTERIOR AGUDA (IRIDOCICLITIS)
Presión Intraocular (PIO)	Muy elevada (> 50–70 mmHg) · Ojo pétreo	Normal o disminuida (hipotonía por hiposecreción ciliar)
Pupila	MIDRIASIS MEDIA FIJA, ovalada, arreactiva	MIOSIS unilateral, hiporreactiva, bordes irregulares
Córnea	Edema difuso epitelial en vidrio esmerilado	Transparente con precipitados queráticos retrocorneales
Cámara anterior	Muy estrecha o plana (bloqueo pupilar)	Profundidad normal, con células inflamatorias (Tyndall)
Dolor y síntomas sistémicos	Dolor lancinante severo + náuseas y vómitos	Dolor sordo moderado + fotofobia sin vómitos
Manejo farmacológico inicial	Hipotensores (Manitol EV + Acetazolamida + Timolol)	Midriáticos (Atropina) + Corticoides tópicos

REGLA DE ORO **Cefalea con vómitos y halos** — Más pupila en midriasis media fija

PRACTICA **Libro Gordo Oftalmología**, preguntas **24–30** (págs. 8–9) · solucionario pág. 20.

Clase 15.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · GLAUCOMA & PATOLOGÍA DEL CRISTALINO

15.7 Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG

★★★ PRIORIDAD ALTA
8 preguntas reales 2013–2025

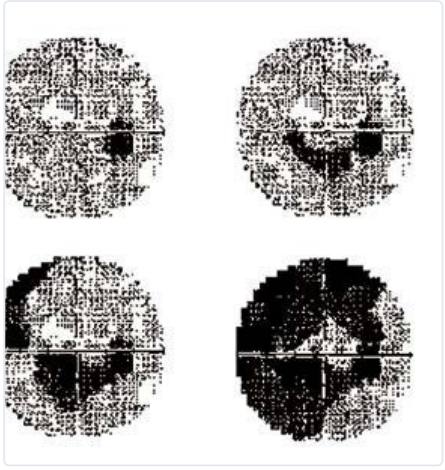
Alta · Causa líder de ceguera silenciosa irreversible; distinción con glaucoma agudo

6.02.1.013 **Glaucoma crónico** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Campo visual · Oftalmoscopía directa · Glaucoma congénito · Instilación de colirios

LO QUE TE PREGUNTAN

- El glaucoma crónico es asintomático y no altera la agudeza visual central hasta fases terminales.
- El signo de sospecha en APS es el aumento de la excavación papilar (>0.5) o asimetría interocular (>0.2).
- La pérdida de campo visual es insidiosa, periférica y avanza hacia visión en túnel.
- El tratamiento médico de primera línea son los Análogos de Prostaglandinas tópicos (Latanoprost nocturno).
- Los análogos de prostaglandinas oscurecen el iris y aumentan el largo de las pestañas.
- El antecedente familiar en padres o hermanos es el factor predictivo más fuerte para pesquisa activa.



PÉRDIDA PROGRESIVA DEL CAMPO
Manual AMIR Oftalmología, p. 35

ALGORITMO · SOSPECHA EN EL FONDO DE OJO: QUÉ HACER PASO A PASO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

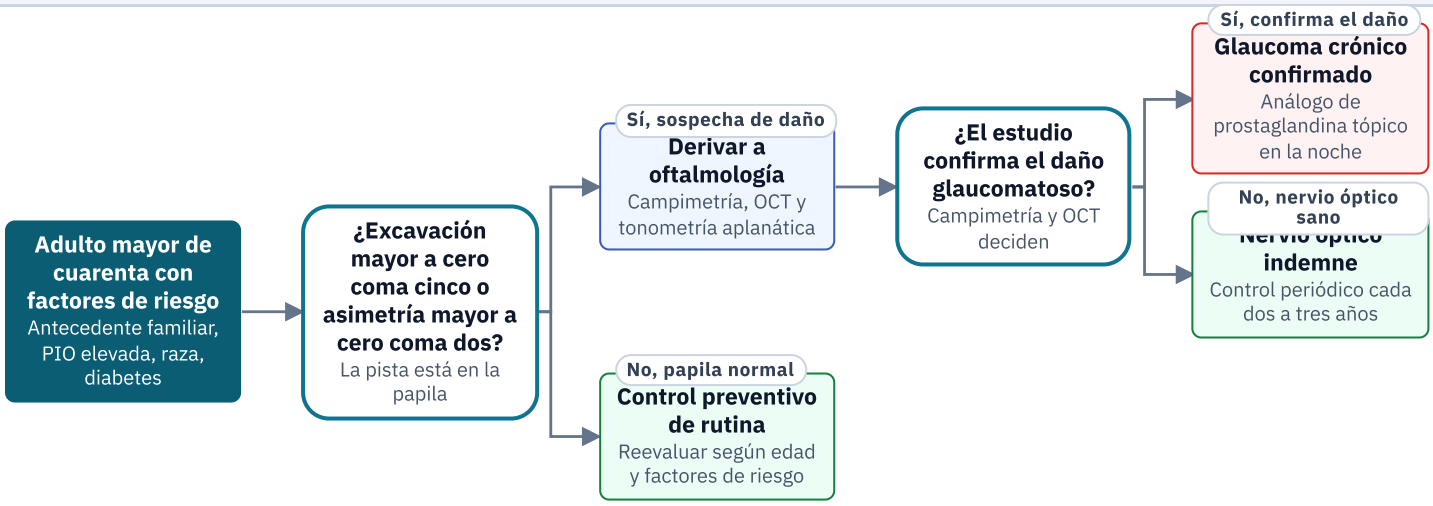


TABLA 15.7 · COMPARACIÓN: GLAUCOMA CRÓNICO DE ÁNGULO ABIERTO VS GLAUCOMA AGUDO DE ÁNGULO CERRADO

CRITERIO	GLAUCOMA CRÓNICO DE ÁNGULO ABIERTO	GLAUCOMA AGUDO DE ÁNGULO CERRADO
Prevalencia	90% de todos los glaucomas (muy común)	10% de los casos (emergencia infrecuente)
Comienzo y síntomas	Totalmente ASINTOMÁTICO durante décadas	Inicio BRUSCO, cefalea intensa, náuseas y vómitos
Aspecto externo del ojo	Completamente BLANCO, normal	OJO ROJO periquerático intenso
Agudeza visual central	Normal 20/20 hasta etapas terminales	Caída visual SEVERA e inmediata
Campo visual	Pérdida periférica concéntrica (visión túnel)	Visión borrosa difusa por edema corneal
Presión intraocular	Levemente elevada (22 a 32 mmHg) o normal	Disparada masivamente (> 50 a 80 mmHg) · Ojo pétreo
Fondo de ojo característico	Excavación papilar patológica aumentada (> 0.5)	Edema difuso que impide ver el fondo con claridad
Tratamiento de elección	Colirios de por vida (Latanoprost nocturno)	Manitol EV + Acetazolamida + Iridotomía láser YAG

REGLA DE ORO **Veinte veinte hasta el final** — El glaucoma crónico no baja la visión central hasta fases terminales

PRACTICA **Libro Gordo Oftalmología**, preguntas **31–34** (pág. 9) · solucionario págs. 20–21.

Clase 15.7 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · GLAUCOMA & PATOLOGÍA DEL CRISTALINO

15.8 Cataratas: Diagnóstico, Indicación Quirúrgica y Facoemulsificación

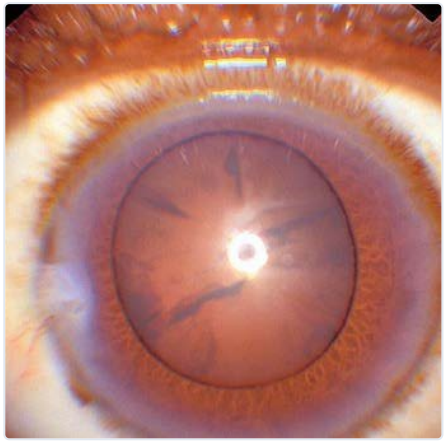
★★★ PRIORIDAD ALTA
5 preguntas reales 2013–2025

6.02.1.003 Catarata — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Disminución de la visión (lenta vs súbita)

LO QUE TE PREGUNTAN

- La catarata es la causa número uno de ceguera reversible en Chile y en el mundo.
- Cursa con baja visual lenta, progresiva e indolora, con deslumbramiento y pérdida del reflejo rojo.
- La esclerosis nuclear produce miopización temporal ("el paciente vuelve a leer sin lentes de cerca").
- El uso crónico de corticoides (tópicos o sistémicos) induce catarata subcapsular posterior en jóvenes.
- **El tratamiento definitivo es exclusivamente quirúrgico**: Facoemulsificación con implante de lente intraocular (LIO).
- El problema GES N° 21 garantiza la cirugía en menos de **90 días** desde la confirmación diagnóstica.



CATARATA
Manual AMIR Oftalmología, p. 40

ALGORITMO · BAJA VISUAL LENTA E INDOLORA: CONFIRMA CON EL REFLEJO ROJO

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

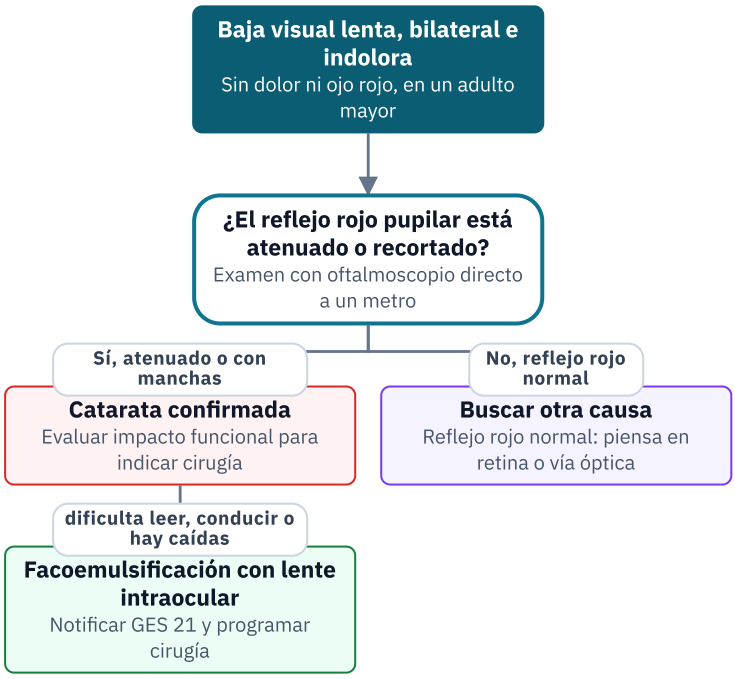


TABLA 15.8 · SUBTIPOS ANATÓMICOS DE CATARATA Y CARACTERÍSTICAS CLAVE

SUBTIPO DE CATARATA	LOCALIZACIÓN EN EL CRISTALINO	ETIOLOGÍA / FACTOR ASOCIADO	EFECTO CLÍNICO TÍPICO
Nuclear	Núcleo central del cristalino	Envejecimiento senil fisiológico	Miopización paradójica ("vuelve a leer de cerca")
Cortical	Corteza periférica (radios de rueda)	Senil, diabetes mellitus	Deslumbramiento nocturno con luces de autos
Subcapsular Posterior	Cara anterior de la cápsula posterior	USO DE CORTICOIDES, diabetes, jóvenes	Caída visual rápida diurna; mala visión con miosis
Traumática	Fibras subcapsulares / ecuador	Contusión ocular o herida penetrante	Opacidad en roseta estrellada monocular

REGLA DE ORO **Baja visual lenta, bilateral, indolora** — Con atenuación del reflejo rojo

PRACTICA **Libro Gordo Oftalmología**, preguntas **35–36** (pág. 10) · solucionario pág. 21.

Clase 15.8 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · GLAUCOMA & PATOLOGÍA DEL CRISTALINO

15.9 Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

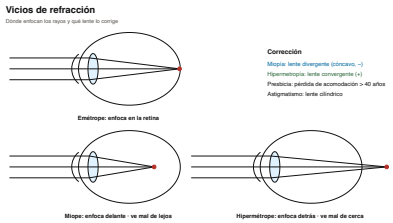
★★★ PRIORIDAD ALTA
8 preguntas reales 2013–2025

6.02.1.001 Ametropía — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Estrabismo · Vicios de refracción en personas de 65 años o más · Examen visual preventivo en niños · Vicios de refracción · Hemangiomas y malformaciones vasculares del recién nacido · Tumores endoculares (retinoblastoma y otros) · Examen visual en adulto · Cover test · Examen de rojo pupilar con oftalmoscopio · Test de Hirschberg (imagen especular de la córnea) · Toma de visión

LO QUE TE PREGUNTAN

- La miopía tiene el ojo largo, ve mal de lejos y se corrige con lentes divergentes cóncavos (-).
- La hipermetropía tiene el ojo corto, fatiga ocular de cerca y se corrige con lentes convergentes convexos (+).
- El astigmatismo se debe a curvatura corneal asimétrica y se corrige con lentes cilíndricos/tóricos.
- La presbicia es la pérdida de acomodación fisiológica del cristalino a partir de los **40-45 años**.
- La prueba del agujero estenopeico mejora la visión en vicios de refracción y no mejora en patología orgánica.
- La ambliopía se trata tapando el ojo sano con parche y debe resolverse obligatoriamente antes de los **7-8 años**.



VICIOS DE REFRACCIÓN
Dibujo propio (esquema)

ALGORITMO · BAJA VISUAL SIN DOLOR NI OJO ROJO: LA PREGUNTA ES EL AGUJERO ESTENOPEICO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

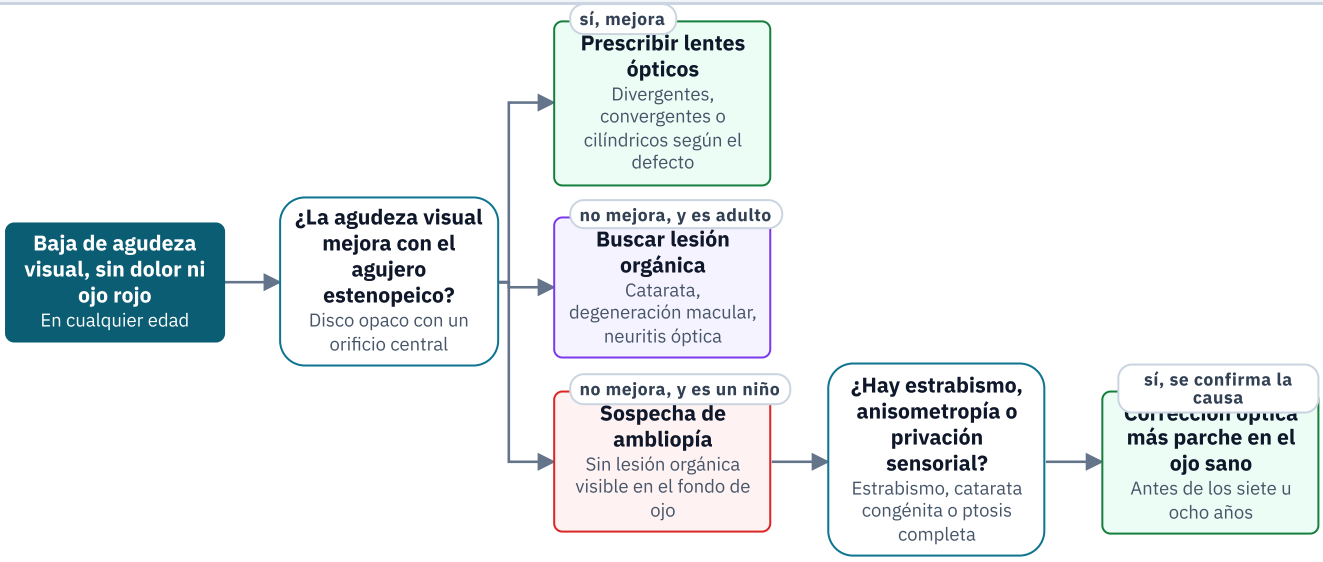


TABLA 15.9 · RESUMEN COMPARATIVO DE VICIOS DE REFRACCIÓN Y PRESBICIA

TRASTORNO	MECANISMO ÓPTICO	SÍNTOMA CARDINAL	LENTE DE CORRECCIÓN	COMPLICACIÓN / RIESGO
Miopía	Globo ocular largo; foco por delante de retina	Mala visión de lejos; buena visión de cerca	Divergente / Cóncavo (-)	Desprendimiento de retina, glaucoma crónico
Hipermetropía	Globo ocular corto; foco por detrás de retina	Astenopía, cefalea vespertina de lectura	Convergente / Convexo (+)	Glaucoma agudo por ángulo estrecho, estrabismo
Astigmatismo	Curvatura corneal irregular en meridianos	Visión distorsionada de lejos y de cerca	Cilíndrico / Tórico	Astenopía, fatiga ocular crónica
Presbicia	Pérdida fisiológica de elasticidad del cristalino	Incapacidad de leer de cerca > 40-45 años	Lentes positivos para cerca (+)	Pérdida de autonomía en adultos maduros
Ambliopía	Falta de maduración cortical por privación/estrabismo	Baja visual monocular irreversible si > 8 años	Parche en ojo sano + lentes	Ceguera funcional permanente del adulto

REGLA DE ORO **Mejora: vicio de refracción** — No mejora: lesión orgánica o ambliopía

PRACTICA **Libro Gordo Oftalmología**, preguntas **1–2, 51–54** (págs. 6, 11–12) · solucionario págs. 17, 23–24.

Clase 15.9 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · PÉRDIDA SÚBITA DE VISIÓN & RETINA

15.10 Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo

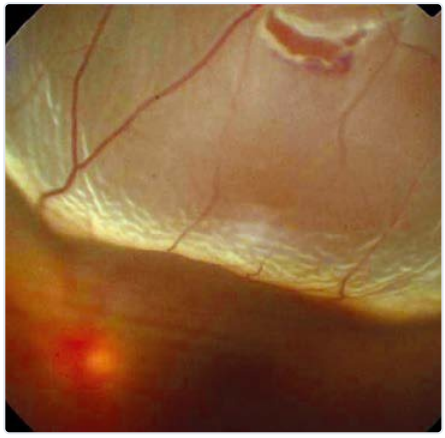
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
2 preguntas reales 2013–2025

6.02.2.003 Desprendimiento de retina — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Disminución de la visión (lenta vs súbita)

LO QUE TE PREGUNTAN

- El desprendimiento de retina regmatógeno es INDOLORO y cursa con OJO BLANCO.
- **Secuencia cardinal**: 1° Fotopsias + miodesopsias bruscas, 2° Cortina o sombra negra periférica que avanza.
- El principal factor de riesgo predisponente es la Miopía Magna (miopía alta).
- Si la mácula está aplicada ("mácula on"), es una urgencia quirúrgica máxima (< **24-48 horas**) para evitar la ceguera central.
- El problema GES N° 22 cubre el tratamiento quirúrgico del desprendimiento de retina.
- En APS la conducta es reposo en cama, régimen cero y derivación de urgencia; no se dan colirios.



DESGARRO EN HERRADURA
Manual AMIR Oftalmología, p. 13

ALGORITMO · FOTOPSIAS Y MIODESOPSIAS AGUDAS: SIGUE LA SECUENCIA HASTA LA MÁCULA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

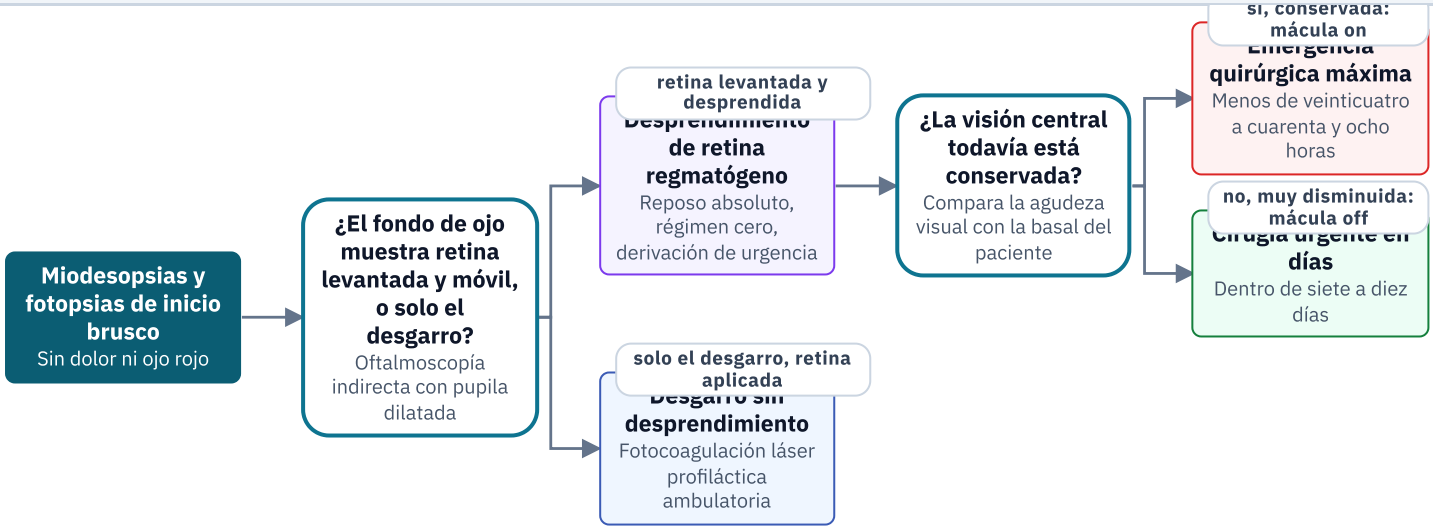


TABLA 15.10 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ETIOLÓGICO DEL DESPRENDIMIENTO DE RETINA

TIPO DE DESPRENDIMIENTO	MECANISMO FISIOPATOLÓGICO	FACTORES DE RIESGO / CAUSA	MANEJO DE ELECCIÓN
Regmatógeno (DRR)	Rotura retiniana + paso de vítreo líquido	Miopía magna, cirugía catarata previa, trauma	Vitrectomía pars plana / Cerclaje escleral (GES)
Traccional	Membranas fibrovasculares contraen la retina	Retinopatía diabética proliferativa no controlada	Vitrectomía con corte de bandas fibróticas
Exudativo / Seroso	Trasudación por alteración del EPR / coroides	Tumores (melanoma), coroiditis, preeclampsia	Tratamiento etiológico médico; no quirúrgico

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

TIPO	MECANISMO	CAUSA TÍPICA	MANEJO DE ELECCIÓN
Cualquier tipo	Sospecha clínica sin pródromos	Confundir con hemorragia vítrea	El desprendimiento avanza en cortina; la hemorragia da humo rojizo

REGLA DE ORO **Miodesopsias, luego fotopsias** — Después, una cortina que avanza

PRACTICA **Libro Gordo Oftalmología**, preguntas **39–48** (págs. 10–11) · solucionario págs. 21–23.

Clase 15.10 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · PÉRDIDA SÚBITA DE VISIÓN & RETINA

15.11 Oclusión Vascular Retinal: Arteria (Mancha Rojo Cereza) vs Vena Central

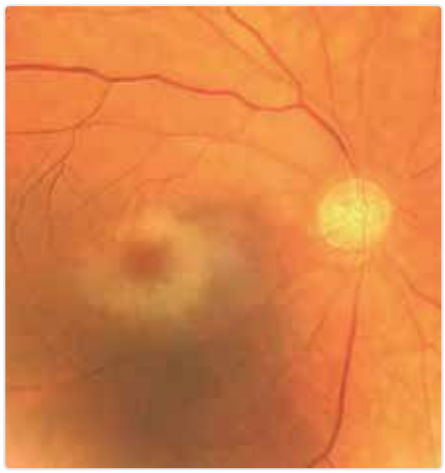
PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

Muy alta · Diagnóstico diferencial semiológico y reconocimiento de la mancha rojo cereza

6.02.2.004 **Disminución de la visión (lenta vs súbita)** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- **OACR** = pérdida súbita masiva indolora en segundos + retina pálida + MANCHA ROJO CEREZA foveal.
- **OVCR** = pérdida subaguda indolora + HEMORRAGIAS EN LLAMARADA en 4 cuadrantes ("pizza marinara").
- Ambas cursan con ojo estrictamente BLANCO e INDOLORO.
- La OACR en mayores de **65 años** exige descartar Arteritis de Horton (VHS y PCR de urgencia; corticoides EV).
- La OVCR isquémica tiene alto riesgo de Glaucoma Neovascular a los **90 días** ("glaucoma de los **100 días**").
- Todo paciente con OACR debe estudiarse con ecografía Doppler carotídea y ECG/Holter como si fuera un ACV.



MANCHA ROJO CEREZA
Manual CTO Oftalmología 14.ª ed., p. 70

ALGORITMO · PÉRDIDA MONOCULAR SÚBITA E INDOLORA, CON EL OJO BLANCO: MIRA EL FONDO DE OJO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

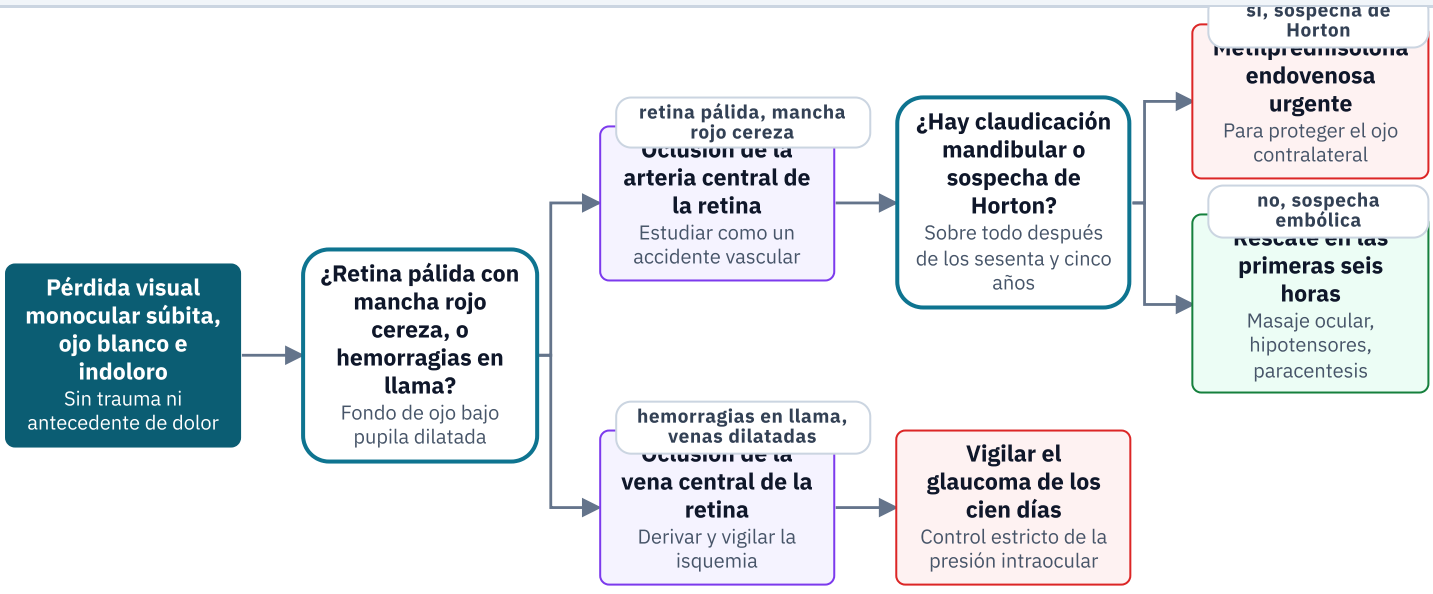


TABLA 15.11 · OCLUSIÓN ARTERIAL VS OCLUSIÓN VENOSA RETINAL: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE EXAMEN

CARACTERÍSTICA	OCLUSIÓN ARTERIAL (OACR)	OCLUSIÓN VENOSA (OVCR)
Velocidad de inicio	BRUSCA en segundos ("pantalla negra")	Rápida o subaguda en horas a días
Pérdida visual	Masiva y profunda (cuenta dedos / no luz)	Variable, moderada a severa
Fondo de ojo patognomónico	Retina blanca/pálida + MANCHA ROJO CEREZA foveal	HEMORRAGIAS EN LLAMARADA en 4 cuadrantes
Etiología principal	Émbolo carotídeo o cardíaco / Arteritis de Horton	Trombosis venosa asociada a HTA y glaucoma
Complicación a los 90 días	Atrofia óptica pálida irreversible	GLAUCOMA NEOVASCULAR ("glaucoma de los 100 días")
Estudio sistémico prioritario	Eco-Doppler carotídeo + ECG/Holter + VHS/PCR	Perfil lipídico, HTA, coagulopatías, seguimiento PIO

REGLA DE ORO **Rojo cereza: arterial** — Hemorragias en llama: venosa

PRACTICA **Libro Gordo Oftalmología**, preguntas **49–50** (pág. 11) · solucionario pág. 23.

Clase 15.11 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · PÉRDIDA SÚBITA DE VISIÓN & RETINA

15.12 Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES

★★★ PRIORIDAD ALTA
5 preguntas reales 2013–2025

6.02.1.023
1.02.1.015
Retinopatía diabética

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Diabetes · Hemorragia vítrea

LO QUE TE PREGUNTAN

- La retinopatía diabética es la primera causa de ceguera irreversible en personas en edad laboral.
- El tamizaje en DM2 se realiza AL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO y luego ANUALMENTE.
- En DM1 el tamizaje se inicia a los **5 años** del diagnóstico.
- La presencia de NEOVASOS define a la Retinopatía Diabética Proliferativa y exige Panfotocoagulación Láser.
- La causa más frecuente de baja de visión en diabéticos es el Edema Macular Diabético (se trata con anti-VEGF intravítreos).
- El edema macular puede aparecer en cualquier etapa de la enfermedad (tanto no proliferativa como proliferativa).



HEMORRAGIAS Y EXUDADOS
Manual CTO Oftalmología 14.ª ed., p. 67

ALGORITMO · PACIENTE DIABÉTICO: SIGUE EL TAMIZAJE HASTA EL NEOVASO

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

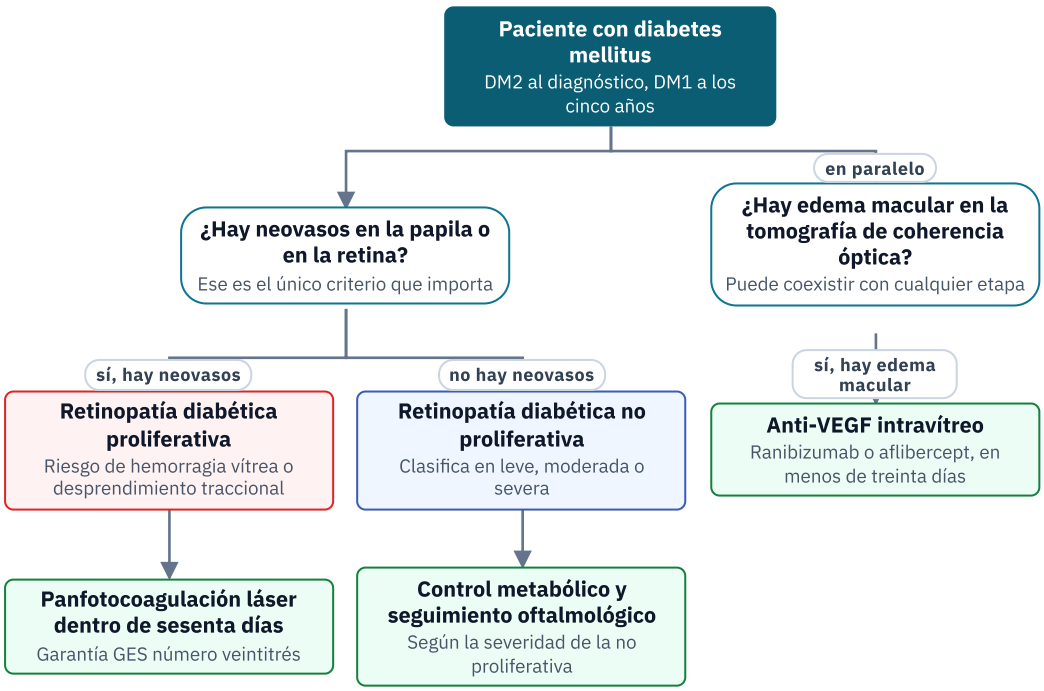


TABLA 15.12 · DIFERENCIACIÓN FUNDAMENTAL: RD NO PROLIFERATIVA VS PROLIFERATIVA

CARACTERÍSTICA	RETINOPATÍA NO PROLIFERATIVA (RDNP)	RETINOPATÍA PROLIFERATIVA (RDP)
Criterio diagnóstico definitorio	Ausencia total de neovasos retinianos	PRESENCIA DE NEOVASOS (en papila o retina)
Lesiones típicas	Microaneurismas, exudados duros y blandos	Neovasos, tejido fibroso, hemorragias vítreas
Riesgo mayor de ceguera	Edema macular diabético	Hemorragia vítrea masiva y desprendimiento traccional
Tratamiento de elección	Control estricto de HbA1c + Anti-VEGF si edema	PANFOTOCOAGULACIÓN LÁSER (PPR) urgente
Seguimiento oftalmológico	Anual si leve; cada 4-6 meses si moderada/severa	Cada 1 a 3 meses por especialista

REGLA DE ORO **Sin neovasos: no proliferativa** — Con neovasos: proliferativa, sin excepción

PRACTICA **Libro Gordo Oftalmología**, preguntas **20, 57–62** (págs. 8, 12–13) · solucionario págs. 19, 24–25.

Clase 15.12 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · PÉRDIDA SÚBITA DE VISIÓN & RETINA

15.13 Retinopatía Hipertensiva: Cruces AV, Exudados Algodonosos y Edema Papilar

PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

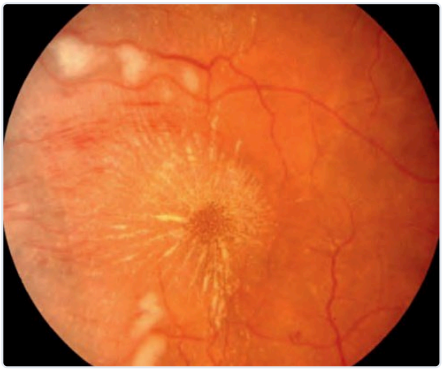
Alta · La presencia de edema de papila (Grado IV) define emergencia hipertensiva maligna

6.02.3.005 **Hipertensión arterial** — Conocimiento general

También: Crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas · Oftalmoscopía directa

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Grado I** = arterias en hilo de cobre; Grado II = cruces AV (signo de Gunn y Salus).
- **Grado III** = hemorragias en llama + exudados algodonosos por isquemia.
- **Grado IV** = todo lo anterior + EDEMA DE PAPILA BILATERAL.
- El Grado IV define una Emergencia Hipertensiva Maligna y exige ingreso a UCI y fármacos EV.
- **NUNCA descender la presión arterial bruscamente**: bajar solo un **20-25%** de la PAM en las primeras **2 horas**.
- El signo de Gunn es la compresión y afilamiento venoso en el cruce arteriovenoso.



HILO DE COBRE Y CRUCES
Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 570

ALGORITMO · FONDO DE OJO DEL PACIENTE HIPERTENSO: SIGUE EL HALLAZGO HASTA LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

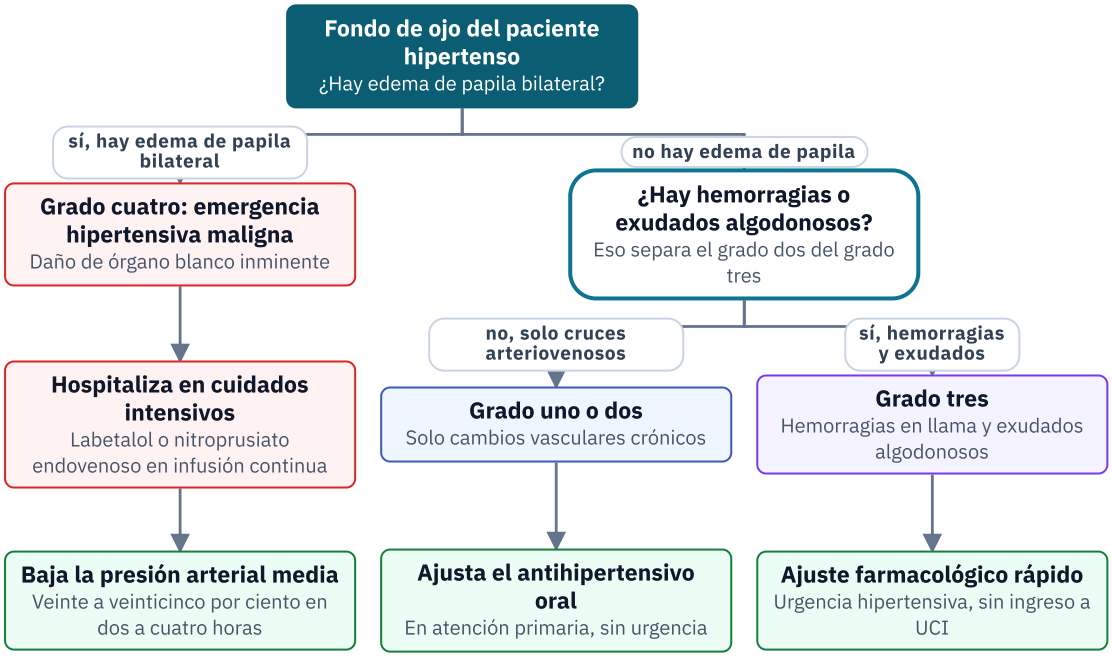


TABLA 15.13 · CLASIFICACIÓN DE KEITH-WAGENER-BARKER DE LA RETINOPATÍA HIPERTENSIVA

GRADO	HALLAZGOS AL FONDO DE OJO	FISIOPATOLOGÍA SUBYACENTE	CONDUCTA CLÍNICA
Grado I	Estrechamiento arteriolar leve, arterias en "hilo de cobre"	Vasoconstricción funcional / esclerosis incipiente	Manejo ambulatorio en APS (GES HTA N° 3)
Grado II	Arterias en "hilo de plata", cruces AV patológicos (Gunn y Salus)	Esclerosis marcada de la adventicia compartida	Optimizar terapia antihipertensiva oral
Grado III	Hemorragias en llama, exudados algodonosos, estrella macular	Necrosis fibrinoide e isquemia retiniana aguda	Urgencia hipertensiva; ajuste farmacológico rápido
Grado IV	Todo lo anterior + EDEMA DE PAPILA BILATERAL	Hipertensión intracraneana / Hipertensión maligna	EMERGENCIA HIPERTENSIVA: UCI + Fármacos EV

REGLA DE ORO **Uno: hilo de cobre. Dos: signo de Gunn o Salus** — Solo cambios vasculares crónicos

PRACTICA **Libro Gordo Oftalmología**, preguntas **63–64** (pág. 13) · solucionario pág. 25.

Clase 15.13 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · PÉRDIDA SÚBITA DE VISIÓN & RETINA

15.14 Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y Escotoma Central

★★★ PRIORIDAD ALTA
5 preguntas reales 2013–2025

Alta · Principal causa de ceguera central legal irreversible en adultos mayores; rejilla de Amsler

6.02.1.010 Degeneración macular relacionada a la edad — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- La DMAE es la causa líder de ceguera central legal en adultos mayores de **60 años**.
- **Metamorfopsia** = ver líneas rectas como onduladas; se evalúa con la Rejilla de Amsler.
- Cursa con escotoma central pero con RESPETO ABSOLUTO del campo visual periférico (nunca ceguera total).
- El tabaquismo es el principal factor de riesgo ambiental modificable.
- La DMAE seca se maneja con antioxidantes orales (AREDS-2); la húmeda requiere inyecciones anti-VEGF intravítreas.
- Las drusas blandas y confluentes son la lesión elemental precursora de degeneración macular.



DRUSAS
Manual CTO Oftalmología 14.ª ed., p. 72

ALGORITMO · PACIENTE CON METAMORFOPSIA: DECIDE ENTRE LA FORMA SECA Y LA HÚMEDA

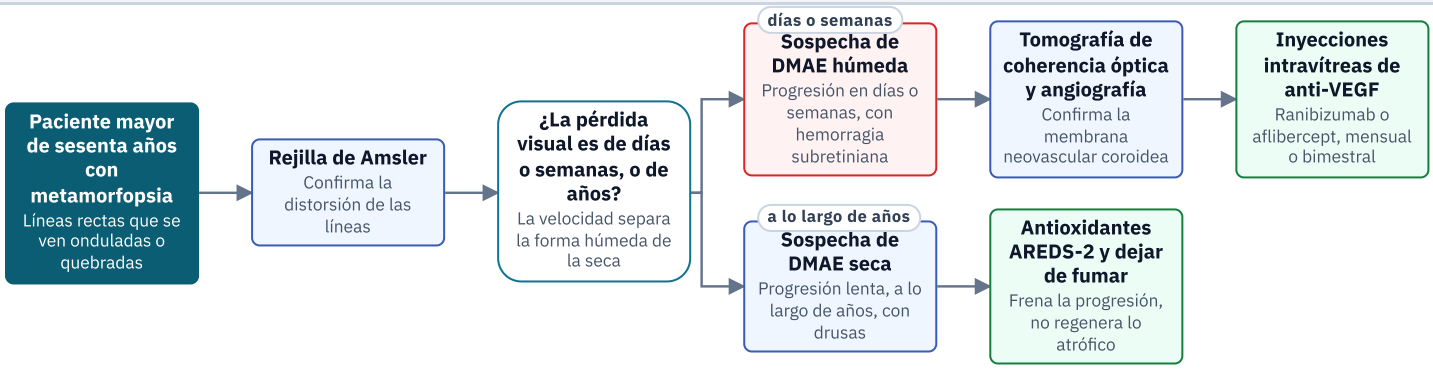


TABLA 15.14 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: DMAE SECA (ATRÓFICA) VS DMAE HÚMEDA (EXUDATIVA)

CARACTERÍSTICA	DMAE SECA (ATRÓFICA)	DMAE HÚMEDA (EXUDATIVA)
Frecuencia	85% a 90% de los pacientes con DMAE	10% a 15% de los casos (la más destructiva)
Velocidad de pérdida visual	LENTA y progresiva a lo largo de años	RÁPIDA y brusca en semanas o meses
Fisiopatología	Drusas + atrofia progresiva del EPR	Membrana neovascular coroidea con edema y sangre
Fondo de ojo característico	Drusas amarillentas y zonas de atrofia despigmentada	Hemorragias subretinianas, líquido seroso, cicatriz
Herramienta de detección	Rejilla de Amsler periódica	Rejilla de Amsler + OCT macular + Angiografía
Tratamiento de elección	Antioxidantes orales (AREDS-2) + Dejar de fumar	INYECCIONES INTRAVÍTREAS DE ANTI-VEGF urgentes

REGLA DE ORO **Líneas rectas onduladas** — El síntoma más temprano; se pesquisa con la rejilla de Amsler

PRACTICA **Libro Gordo Oftalmología**, preguntas **65–67** (págs. 13–14) · solucionario pág. 25.

Clase 15.14 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · TRAUMA OCULAR & NEUROFTALMOLOGÍA

15.15 Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta

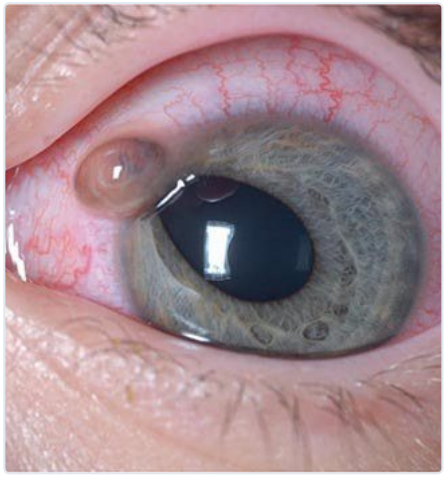
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
2 preguntas reales 2013–2025

6.02.2.007 Herida penetrante o perforante ocular — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Hifema · Contusión ocular · Colocación de sello ocular · Trauma maxilofacial · Heridas de párpados · Accidentes del trabajo · Eversión palpebral · Extracción de cuerpo extraño tarsal

LO QUE TE PREGUNTAN

- La pupila en gota o lágrima apunta directamente hacia el sitio de la perforación corneal o escleral.
- **PROHIBICIONES EN GLOBO ABIERTO**: NO comprimir, NO palpar, NO medir PIO, NO colocar pomadas ni colirios.
- El ojo debe protegerse con una concha rígida fenestrada que apoye en el hueso orbitario, NUNCA con parche compresivo.
- Siempre administrar antieméticos EV (ondansetrón) para evitar el vómito y la expulsión de tejido intraocular.
- El examen imagenológico de elección es el TAC de órbita sin contraste; la Resonancia Magnética está PROHIBIDA ante CEIO.
- El hipema traumático requiere reposo semisentado a 45° para evitar la oclusión pupilar y el resangrado a las **72h**.



PUPILA EN GOTA
The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 93

ALGORITMO · TRAUMA OCULAR EN URGENCIAS: SIGUE LOS SIGNOS HASTA LA CONDUCTA CORRECTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

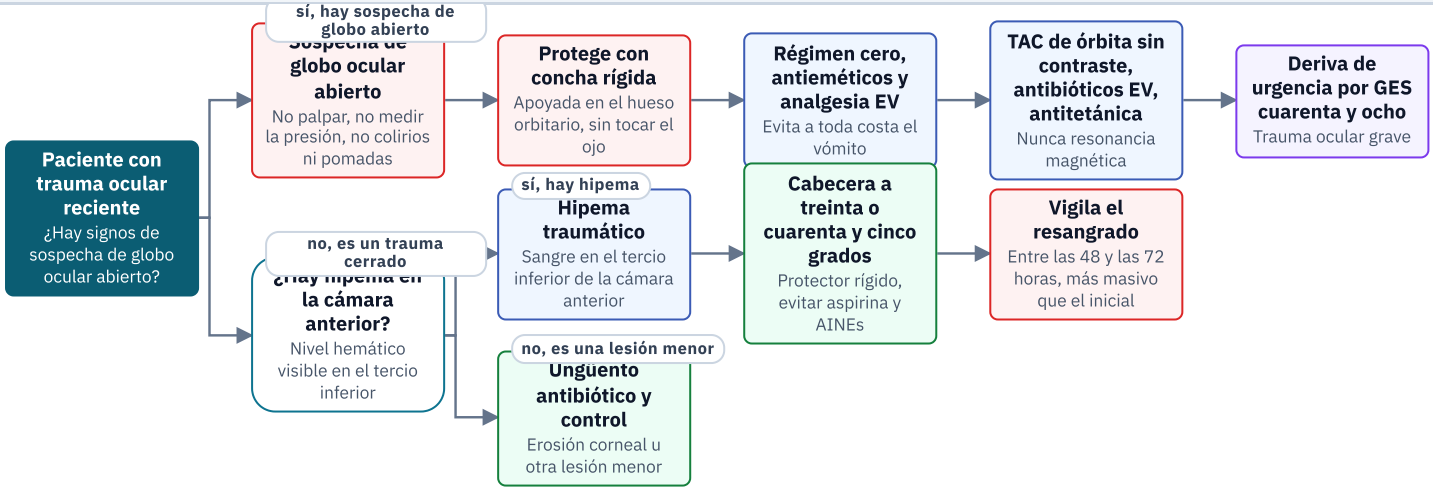


TABLA 15.15 · SIGNOS DE CERTEZA VS SOSPECHA DE GLOBO OCULAR ABIERTO

CATEGORÍA SEMIOLÓGICA	HALLAZGOS AL EXAMEN FÍSICO	MECANISMO FISIOPATOLÓGICO	CONDUCTA INMEDIATA
Signo de Certeza	Pérdida de contenido ocular (tejido uveal/vítreo visible)	Evisceración traumática por solución de continuidad	Concha rígida + Antibiótico EV + Pabellón urgente
Signo de Certeza	Presencia de cuerpo extraño intraocular en TAC	Herida penetrante metálica a alta velocidad	TAC órbita sin contraste; RM CONTRAINDICADA
Signo de Sospecha Alta	Pupila en gota o lágrima que apunta a la herida	Herniación del iris hacia el orificio perforante	No tocar; proteger con concha ósea rígida
Signo de Sospecha Alta	Cámara anterior muy estrecha / Seidel positivo	Fuga activa de humor acuoso a través de la córnea	Prohibidas pomadas y tonometría
Signo de Sospecha Alta	Hiposfagma masivo 360° + quemosis bullosa severa	Ruptura escleral oculta posterior bajo conjuntiva	Derivación GES N° 48 de urgencia

REGLA DE ORO **Pupila en gota, hipotonía, Seidel positivo** — Cámara anterior anormal, protrusión de tejido, hiposfagma en 360°

PRACTICA **Libro Gordo Oftalmología**, preguntas **19, 38, 68–72** (págs. 8, 10, 14) · solucionario págs. 19, 21, 26.

Clase 15.15 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · TRAUMA OCULAR & NEUROFTALMOLOGÍA

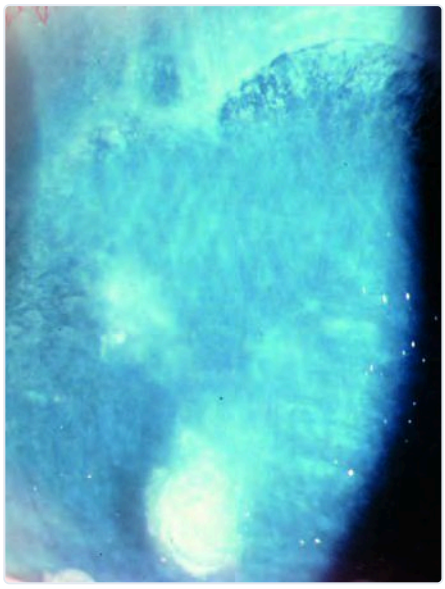
15.16 Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
2 preguntas reales 2013–2025

6.02.2.001 Causticaciones oculares — Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Ante una quemadura química ocular**: SE LAVA PRIMERO Y SE PREGUNTA DESPUÉS.
- Está PROHIBIDO retrasar el lavado para medir la agudeza visual o tomar la ficha clínica.
- Los álcalis (soda cáustica, cal, cemento) son más destructivos que los ácidos por necrosis de licuefacción.
- El lavado debe durar mínimo **20 a 30 minutos** con 1 a 2 litros de suero salino o agua corriente.
- Es obligatorio evertir los párpados para remover partículas sólidas de cal atrapadas en los fondos de saco.
- La meta es la neutralización del pH conjuntival (7.0 a 7.5), verificada **10 minutos** post-lavado.
- El "ojo blanco" en el limbo esclerocorneal indica isquemia límbica severa y pronóstico nefasto.



QUEMADURA QUÍMICA GRAVE
Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 895

ALGORITMO · PACIENTE CON QUEMADURA QUÍMICA OCULAR: QUÉ SE HACE PRIMERO Y CÓMO SE DECIDE EL PRONÓSTICO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

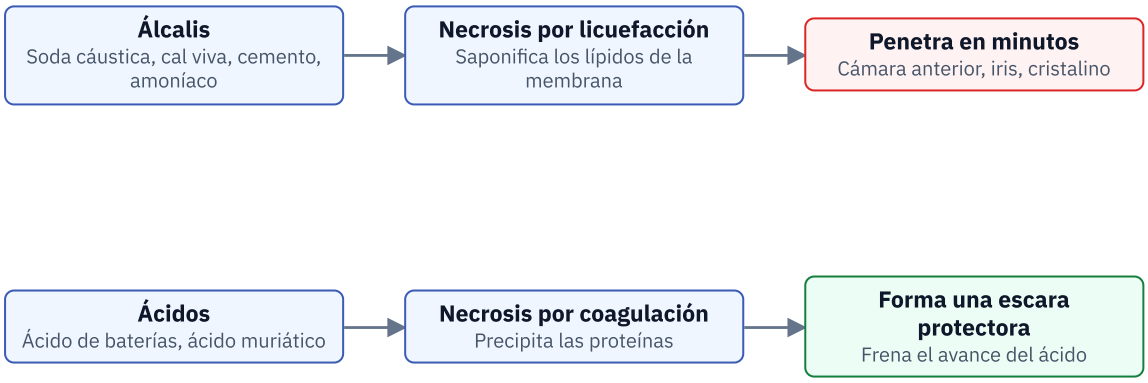


TABLA 15.16 · COMPARACIÓN ENTRE QUEMADURAS QUÍMICAS OCULARES POR ÁLCALIS Y ÁCIDOS

CARACTERÍSTICA	QUEMADURA POR ÁLCALIS (BASES)	QUEMADURA POR ÁCIDOS
Sustancias frecuentes	Soda cáustica, cal, cemento, amoníaco, lavavajillas	Ácido de baterías (sulfúrico), ácido muriático
Tipo de necrosis	NECROSIS POR LICUEFACCIÓN y saponificación	NECROSIS POR COAGULACIÓN
Profundidad de daño	PROFUNDA y progresiva; penetra a cámara anterior	Superficial; la escara proteica frena el avance
Gravedad clínica	Extremadamente GRAVE y destructiva	Moderada a severa (menor que álcalis)
Signo de mal pronóstico	Isquemia límbica (limbo blanquecino en porcelana)	Erosiones epiteliales y necrosis conjuntival
Conducta inmediata	LAVADO PROFUSO CON SUERO > 20-30 MINUTOS	LAVADO PROFUSO CON SUERO > 20-30 MINUTOS

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

CARACTERÍSTICA	ÁLCALIS	ÁCIDOS
Trampa clásica	Neutralizar con un ácido débil	Medir agudeza visual antes de lavar

REGLA DE ORO **Lavado inmediato, sin trámites antes** — Ni ficha, ni agudeza visual, ni esperar al especialista

PRACTICA **Libro Gordo Oftalmología**, preguntas **75–77** (pág. 15) · solucionario págs. 26–27.

Clase 15.16 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · TRAUMA OCULAR & NEUROFTALMOLOGÍA

15.17 Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
2 preguntas reales 2013–2025

Máxima rentabilidad · Diagnóstico diferencial semiológico crítico entre celulitis preseptal y orbitaria

2.01.1.005 Celulitis periorbitaria — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Tumores de órbita

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Celulitis preseptal** = movimientos oculares normales e INDOLOROS, sin proptosis y visión 20/20.
- **Celulitis orbitaria** = OFTALMOPLEJÍA DOLOROSA, PROPTOSIS y disminución de agudeza visual.
- La principal causa de celulitis orbitaria es la Sinusitis Etmoidal aguda complicada.
- La celulitis preseptal se trata ambulatoriamente con Amoxicilina-Clavulánico oral.
- La celulitis orbitaria requiere HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA + Antibióticos EV triples + TAC de órbita con contraste.
- La bilateralización del cuadro con oftalmoplejía completa alerta de Trombosis del Seno Cavernoso.



CELULITIS PRESEPTAL
Manual AMIR Oftalmología, p. 43

ALGORITMO · PÁRPADO ROJO E HINCHADO: DECIDE ENTRE CELULITIS PRESEPTAL Y ORBITARIA

☐ urgencia ☐ resuelve ☐ derivar ☐ examen/acción

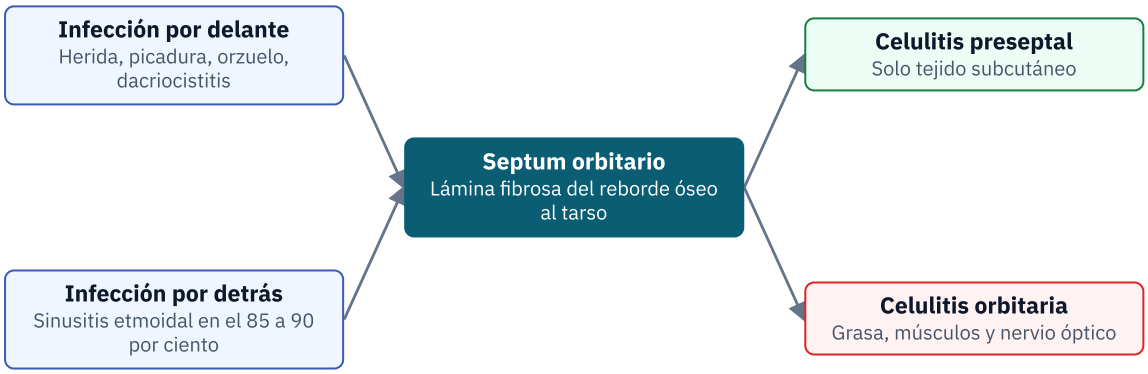


TABLA 15.17 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO: CELULITIS PRESEPTAL VS CELULITIS ORBITARIA

HALLAZGO CLÍNICO	CELULITIS PRESEPTAL (PERIORBITARIA)	CELULITIS ORBITARIA (POSTSEPTAL)
Localización anatómica	Anterior al septum orbitario (tejido subcutáneo)	Posterior al septum orbitario (grasa y músculos)
Origen habitual	Infección cutánea, picadura, traumatismo, orzuelo	Sinusitis paranasal aguda (especialmente etmoidal)
Motilidad ocular	NORMAL E INDOLORA en todos los ejes	OFTALMOPLEJÍA DOLOROSA (limitada y con dolor)
Proptosis / Exoftalmos	AUSENTE	PRESENTE (protrusión ocular unilateral)
Agudeza visual y reflejos	NORMALES (20/20)	DISMINUIDA; puede haber DPAR (compromiso nervio)
Estudio de imagen	No requerido de regla si es clara	TAC DE ÓRBITA CON CONTRASTE OBLIGATORIO
Manejo médico	Ambulatorio con Amoxicilina-Clavulánico oral	HOSPITALIZACIÓN INMEDIATA + Antibióticos EV triples

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

HALLAZGO	CELULITIS PRESEPTAL	CELULITIS ORBITARIA
Trampa clásica	Hospitalizar y pedir tomografía de más	Tratar en la casa con antibiótico oral

REGLA DE ORO **Oftalmoplejía dolorosa, proptosis, o baja visual con DPAR** — Cualquiera de los tres confirma orbitaria

PRACTICA **Libro Gordo Oftalmología**, preguntas **78–82** (pág. 15) · solucionario págs. 27–28.

Clase 15.17 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · TRAUMA OCULAR & NEUROFTALMOLOGÍA

15.18 Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn

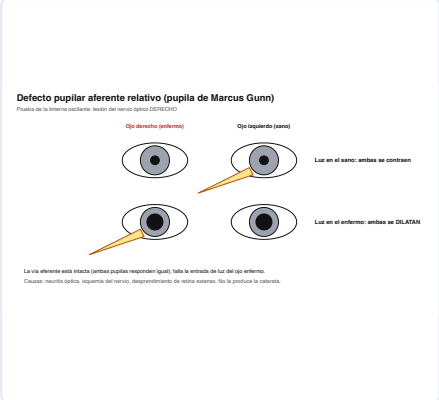
★★★ PRIORIDAD ALTA
6 preguntas reales 2013–2025

6.02.1.016 Neuritis óptica — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Reflejos pupilares · Esclerosis múltiple · Síndrome de hipertensión endocraneana · Tumores SNC · Papiloscopia (fondo de ojo) · Tumores de la vía óptica

LO QUE TE PREGUNTAN

- El DPAR (pupila de Marcus Gunn) es la dilatación paradójica de ambas pupilas al iluminar el ojo enfermo.
- **Neuritis óptica** = dolor con movimientos oculares + baja visual monocular + discromatopsia + DPAR.
- En el **65%** de las neuritis el fondo de ojo es NORMAL ("neuritis retrobulbar").
- La neuritis óptica es el debut clínico clásico de la Esclerosis Múltiple (GES N° 68).
- El papiledema es BILATERAL, con agudeza visual CONSERVADA inicialmente y sin dolor ocular.
- **CONTRAINDICACIÓN**: NUNCA tratar la neuritis con prednisona oral aislada a dosis bajas (aumenta las recidivas).



PUPILA DE MARCUS GUNN
Dibujo propio (esquema)

ALGORITMO · PACIENTE CON PÉRDIDA VISUAL Y SOSPECHA NEUROFTALMOLÓGICA: DECIDE CON LA LINTERNA OSCILANTE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

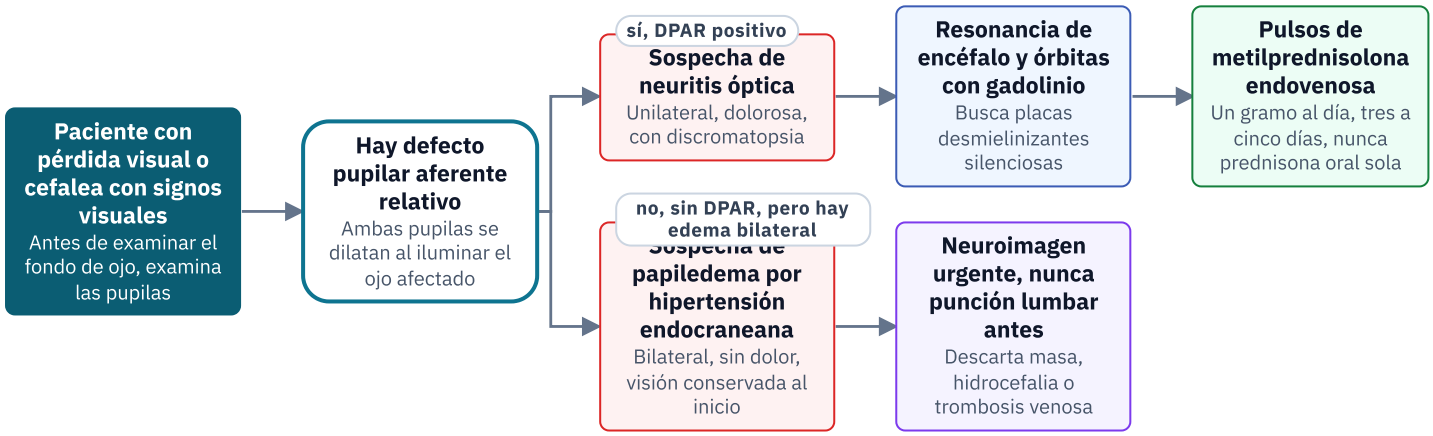


TABLA 15.18 · NEURITIS ÓPTICA RETROBULBAR VS PAPILEDEMA POR HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA

PARÁMETRO	NEURITIS ÓPTICA RETROBULBAR	PAPILEDEMA POR HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA
Lateralidad	Típicamente UNILATERAL (monocular)	Prácticamente siempre BILATERAL
Dolor ocular	PRESENTE en > 90% (empeora al mover el ojo)	AUSENTE; cursa con cefalea matutina y vómitos
Agudeza visual central	CAÍDA BRUSCA y marcada (20/80 a bultos)	CONSERVADA (20/20 inicial); oscurecimientos fugaces
Visión de colores (rojo)	DISCROMATOPSIA SEVERA muy temprana	Normal hasta etapas terminales
Fondo de ojo inicial	NORMAL en 65% ("ni médico ni paciente ven")	EDEMA BILATERAL franco con borramiento papilar
Examen pupilar	DPAR POSITIVO marcado (Marcus Gunn)	Pupilas reactivas normales (sin DPAR)
Patología asociada	Esclerosis Múltiple (desmielinización)	Tumores cerebrales, hidrocefalia, pseudotumor cerebri

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

PARÁMETRO	NEURITIS ÓPTICA RETROBULBAR	PAPILEDEMA
Defecto pupilar aferente	Presente y marcado	Ausente, pupilas normales
Trampa clásica	Descartarla porque el fondo de ojo se ve normal	Puncionar antes de pedir neuroimagen

REGLA DE ORO — **Ambas pupilas se dilatan al iluminar el ojo enfermo** — Signo más sensible de lesión asimétrica del nervio óptico

PRACTICA **Libro Gordo Oftalmología**, preguntas **56, 83–90** (págs. 12, 16) · solucionario págs. 24, 28–29.

Clase 15.18 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

Números que tienes que saber

Cortes, dosis, tiempos y metas de los 18 temas, tal como aparecen en el libro y en las clases. Las cifras van en negrita.

DATO	TIPO
BLOQUE 01 · SÍNDROME DE OJO ROJO & SUPERFICIE OCULAR	
15.1 Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo	pág. 3
Uveítis: derivar en **24 horas** — Queratitis: fluoroquinolona, sin parche	TIEMPO
El hiposfagma es indoloro, no afecta la visión y no requiere tratamiento farmacológico: se resuelve solo en **2 semanas**.	TIEMPO
15.2 Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas	pág. 4
Olopatadina cada **12 horas** — O ketotifeno, más compresas frías	DOSIS
Si no responde en **48 a 72 horas** — Derivar a oftalmología	TIEMPO
Aseo más colirio cada **4 horas** — Cloranfenicol o ciprofloxacino, por **7 días**	DOSIS
Dura más de **4 semanas** o recurre — Casi siempre blefaroconjuntivitis	TIEMPO
15.3 Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis	pág. 5
Masaje de Crigler — Abre sola antes del año en el **90%**	CORTE
Compresas tibias, **3 a 4 veces** al día — Favorecen el drenaje espontáneo	TIEMPO
Doxiciclina oral si hay rosácea — Cien miligramos al día, por **4 a 6 semanas**	TIEMPO
15.4 Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides)	pág. 6
Pomada oftálmica al 3 por ciento — Cinco veces al día, por **10 a 14 días**	TIEMPO
El tratamiento de elección de la queratitis herpética es Aciclovir oftálmico en pomada al **3%** (**5 veces** al día).	TIEMPO
15.5 Escleritis y Epiescleritis: Prueba de Fenilefrina y Enfermedades Reumatológicas	pág. 7
Asociación sistémica · Rara (< **20%**, idiopática habitual) · > **50%** autoinmune (Artritis Reumatoide, Wegener)	CORTE
La prueba de fenilefrina al **2.5%** blanquea la epiescleritis pero NO blanquea la escleritis.	CORTE
BLOQUE 02 · GLAUCOMA & PATOLOGÍA DEL CRISTALINO	
15.6 Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida	pág. 8
La pilocarpina solo es útil cuando la PIO ha bajado a < **30 mmHg** (antes el esfínter pupilar está paralizado).	CORTE
Manejo farmacológico inicial de rescate: Manitol **20%** EV + Acetazolamida oral + Timolol **0.5%** tópico.	CORTE
15.7 Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG	pág. 9
Córnea grande y opaca: buftalmos — Mayor de **11 mm** al nacer, **12 mm** al año	CORTE
Reflejo rojo y luego la papila — Acércate a 2 o **3 cm** siguiendo el reflejo	CORTE
Primero la confiabilidad — Pérdidas de fijación y falsos positivos bajo **20%**	CORTE
El signo de sospecha en APS es el aumento de la excavación papilar (>0.5) o asimetría interocular (>0.2).	CORTE
15.9 Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños	pág. 11
Desde los **60 años** — Control oftalmológico cada **1 a 2 años**	CORTE
Desde los **40 a 45 años** — Presbicia, presión intraocular y papila	CORTE
Crece rápido los primeros meses — Luego involuciona: **50%** a los **5 años**	TIEMPO
Penumbra, a **50 a 80 cm**, ambos ojos a la vez — Oftalmoscopio con el disco en 0	CORTE
BLOQUE 03 · PÉRDIDA SÚBITA DE VISIÓN & RETINA	
15.11 Oclusión Vascular Retinal: Arteria (Mancha Rojo Cereza) vs Vena Central	pág. 13
La OVCR isquémica tiene alto riesgo de Glaucoma Neovascular a los **90 días** ("glaucoma de los **100 días**").	TIEMPO
La OACR en mayores de **65 años** exige descartar Arteritis de Horton (VHS y PCR de urgencia; corticoides EV).	CORTE
15.12 Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES	pág. 14
En DM1 el tamizaje se inicia a los **5 años** del diagnóstico.	CORTE
Seguimiento oftalmológico · Anual si leve; cada **4-6 meses** si moderada/severa · Cada **1 a 3 meses** por especialista	TIEMPO

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
15.13 Retinopatía Hipertensiva: Cruces AV, Exudados Algodonosos y Edema Papilar	pág. 15
Bajar solo un **20 a 25%** de la PAM — En las primeras **2 a 4 horas**, nunca de golpe	TIEMPO
15.14 Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y Escotoma Central	pág. 16
La DMAE es la causa líder de ceguera central legal en adultos mayores de **60 años**.	CORTE
Frecuencia · **85%** a **90%** de los pacientes con DMAE · **10%** a **15%** de los casos (la más destructiva)	CORTE
BLOQUE 04 · TRAUMA OCULAR & NEUROFTALMOLOGÍA	
15.15 Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta	pág. 17
Dolor **6 a 12 horas** después — Erosión punteada bilateral; cura en **24 a 48 horas**	TIEMPO
15.16 Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso	pág. 18
La meta es la neutralización del pH conjuntival (7.0 a 7.5), verificada **10 minutos** post-lavado.	META
El lavado debe durar mínimo **20 a 30 minutos** con 1 a 2 litros de suero salino o agua corriente.	TIEMPO
15.18 Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn	pág. 20
Metilprednisolona **1 g** EV por **3 días** — Acelera la recuperación, no cambia la visión final	DOSIS
La RM basal predice el riesgo — Con 1 o más lesiones, más de **70%** a **15 años**	CORTE
Mujer de **20 a 40 años**, varios territorios — Neuritis, mielitis, oftalmoplejía internuclear, ataxia	CORTE
Color, bordes, elevación, hemorragias, venas — Pulso venoso espontáneo: presente en el **80%** de los normales	CORTE

Fármacos de primera línea

Esquemas de elección por enfermedad, tomados de las tarjetas de tratamiento de cada clase. Al final de la sección, las garantías GES.

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE
15.1 Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo		pág. 3
Glaucoma agudo · Manitol endovenoso	**Más acetazolamida oral y timolol tópico**	
15.2 Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas		pág. 4
Conjuntivitis bacteriana común · Cloranfenicol tópico	**Cloranfenicol o ciprofloxacino, por 7 días**	
El prurito manda · Antihistamínico tópico	**Corticoides: solo con oftalmólogo**	Nunca de primera línea en atención primaria
Conjuntivitis bacteriana crónica · Higiene y ungüento	**Higiene palpebral y eritromicina**	Ungüento nocturno por **2 a 3 semanas**
15.3 Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis		pág. 5
Higiene diaria	**Doxiciclina oral si hay rosácea**	Cien miligramos al día, por **4 a 6 semanas**
15.6 Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida		pág. 8
Bajar la presión ya · Agentes que bajan la presión ahora	**Acetazolamida oral o endovenosa**	Frena la producción de humor acuoso
Bajar la presión ya · Agentes que bajan la presión ahora	**Timolol tópico**	Betabloqueador; también reduce la producción
Bajar la presión ya · Agentes que bajan la presión ahora	**Corticoide tópico**	Prednisolona; controla la inflamación secundaria
15.9 Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños		pág. 11
Propranolol	**Observar lo pequeño; propranolol lo de riesgo**	Uno a tres mg/kg al día, inicio supervisado
15.14 Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y Escotoma Central		pág. 16
DMAE seca · Antioxidantes orales	**Vitamina C, vitamina E, zinc, cobre, luteína y zeaxantina**	
15.15 Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta		pág. 17
El sello ocular, paso a paso · Después del sello	**Ayuno, cabecera a 30 grados, antiemético**	Antibiótico sistémico y cirugía en **24 horas**
15.17 Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC		pág. 19
Celulitis preseptal	**Amoxicilina con ácido clavulánico oral**	Siete a diez días, con control clínico a las veinticuatro horas
15.18 Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn		pág. 20
Hipertensión endocraneana · Conducta inicial	**Idiopática: acetazolamida y bajar de peso**	Control del campo visual para evitar la ceguera

GES de Oftalmología

Garantías Explícitas en Salud que aparecen en los temas de esta especialidad: el EUNACOM pregunta la edad, el examen y el plazo que garantizan.

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 21): Tratamiento Quirúrgico de Cataratas**

Tema **15.8** · Cataratas: Diagnóstico, Indicación Quirúrgica y Facoemulsificación
`6.02.1.003` · `6.02.2.004`
pág. **10**

GES **Garantía Explícita en Salud: Vicios de Refracción en personas de 65 años y más (GES N° 40) y Estrabismo en menores de 9 años (GES N° 41)**

Tema **15.9** · Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños
`6.02.1.001` · `6.02.1.011` · `6.02.1.031`
pág. **11**

Fármacos de primera línea · continuación

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 22): Tratamiento Quirúrgico del Desprendimiento de Retina Regmatógeno No Traumático**

Tema **15.10** · Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo
`6.02.2.003` · `6.02.2.004`
pág. **12**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 23): Retinopatía Diabética**

Tema **15.12** · Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES
`6.02.1.023` · `1.02.1.015` · `6.02.3.002`
pág. **14**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 48): Trauma Ocular Grave**

Tema **15.15** · Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta
`6.02.2.007` · `6.02.1.014` · `6.02.2.002`
pág. **17**

GES **Garantía Explícita en Salud: Incluido en Trauma Ocular Grave GES N° 48**

Tema **15.16** · Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso
`6.02.2.001`
pág. **18**

GES **Garantía Explícita en Salud: Sospecha de Esclerosis Múltiple (GES N° 68)**

Tema **15.18** · Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn
`6.02.1.016` · `6.02.5.011` · `1.10.1.008`
pág. **20**

Sin garantía GES específica (11 temas): 15.1 · 15.2 · 15.3 · 15.4 · 15.5 · 15.6 · 15.7 · 15.11 · 15.13 · 15.14 · 15.17. Revisa igual la norma MINSAL que cita cada página.

Plan de repaso de 7 días

Los temas van de mayor a menor prioridad (★ según preguntas reales EUNACOM 2013–2025). Cada día: lee la página del tema, recorre su algoritmo y haz sus preguntas del Libro Gordo; corrige con el solucionario.

DÍA 1

3 temas · ★★★

- ★★★ **15.7** Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG 9
- ★★★ **15.9** Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños 11
- ★★★ **15.2** Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas 4

Practica: Libro Gordo Oftalmología, preguntas 1–2, 9–11, 31–34, 51–54.

DÍA 2

3 temas · ★★★

- ★★★ **15.3** Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis 5
- ★★★ **15.18** Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn 20
- ★★★ **15.8** Cataratas: Diagnóstico, Indicación Quirúrgica y Facoemulsificación 10

Practica: Libro Gordo Oftalmología, preguntas 12–15, 35–37, 55–56, 73–74, 83–90.

DÍA 3

3 temas · ★★★

- ★★★ **15.12** Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES 14
- ★★★ **15.14** Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y Escotoma Central 16
- ★★☆ **15.1** Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo 3

Practica: Libro Gordo Oftalmología, preguntas 3–8, 20, 57–62, 65–67.

DÍA 4

3 temas · ★★

- ★★☆ **15.6** Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida 8
- ★★☆ **15.4** Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides) 6
- ★★☆ **15.10** Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo 12

Practica: Libro Gordo Oftalmología, preguntas 16–18, 24–30, 39–48.

DÍA 5

3 temas · ★★

- ★★☆ **15.15** Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta 17
- ★★☆ **15.16** Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso 18
- ★★☆ **15.17** Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC 19

Practica: Libro Gordo Oftalmología, preguntas 19, 38, 68–72, 75–82.

DÍA 6

3 temas · ★

- ★☆☆ **15.5** Escleritis y Episcleritis: Prueba de Fenilefrina y Enfermedades Reumatológicas 7
- ★☆☆ **15.11** Oclusión Vascular Retinal: Arteria (Mancha Rojo Cereza) vs Vena Central 13
- ★☆☆ **15.13** Retinopatía Hipertensiva: Cruces AV, Exudados Algodonosos y Edema Papilar 15

Practica: Libro Gordo Oftalmología, preguntas 21–23, 49–50, 63–64.

DÍA 7

- Relee «**Números que tienes que saber**» y «**Fármacos de primera línea**» pág. 21
- Repasa solo las **Trampas EUNACOM** y la **Regla de oro** de los temas ★★★: 15.2 · 15.3 · 15.7 · 15.8 · 15.9 · 15.12 · 15.14 · 15.18
- Simulacro: las **90 preguntas** del Libro Gordo Oftalmología en 120 minutos; vuelve a la página de cada tema que falles.

Índice por prioridad ★

El número a la izquierda es la cantidad de preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) en los códigos Perfil V3 del tema.

★★★ Prioridad alta · 8 temas

8 15.7. Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG 9
8 15.9. Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños GES 11
7 15.2. Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas 4
6 15.3. Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis 5
6 15.18. Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn GES 20
5 15.8. Cataratas: Diagnóstico, Indicación Quirúrgica y Facoemulsificación GES 10
5 15.12. Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES GES 14
5 15.14. Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y Escotoma Central 16

★★ Prioridad media · 7 temas

4 15.1. Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo 3
4 15.6. Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida 8
3 15.4. Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides) 6
2 15.10. Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo GES 12
2 15.15. Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta GES 17
2 15.16. Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso GES 18
2 15.17. Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC 19

★ Prioridad baja · 3 temas

0 15.5. Escleritis y Epiescleritis: Prueba de Fenilefrina y Enfermedades Reumatológicas 7
0 15.11. Oclusión Vascular Retinal: Arteria (Mancha Rojo Cereza) vs Vena Central 13
0 15.13. Retinopatía Hipertensiva: Cruces AV, Exudados Algodonosos y Edema Papilar 15